



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Bioética

Usted es el psiquiatra de una paciente con esquizofrenia paranoide. ¿Considera NECESARIO informar sobre los posibles efectos secundarios de los antipsicóticos que le va a prescribir, como pueden ser el síndrome parkinsoniano o la discinesia tardía?

1. No, porque se corre el riesgo de que la paciente rechace el tratamiento y cause daño a sí misma o a terceros.
2. Se debe evaluar su capacidad de toma de decisiones y, si no es adecuada, se le proporcionará la información a sus familiares o allegados cercanos, así como al paciente en función de su competencia.
3. Sí, ya que si no se violaría el principio de autonomía del paciente.
4. Idealmente se debería proporcionar esta información solamente a la familia, allegados o representante legal, ya que el paciente psiquiátrico se encuentra como normal general incapacitado.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Un paciente psiquiátrico NO debe ser considerado incapaz en todas las situaciones (marcamos la opción de respuesta 2).

-----O-----

Mujer con enfermedad neurodegenerativa en fase avanzada que llega al Servicio de Urgencias del hospital con una infección respiratoria, que ha desencadenado una insuficiencia respiratoria global aguda. La paciente tiene registrada una directriz anticipada. En dichas instrucciones previas señala que no quiere ser sometida a ventilación mecánica. También dejó establecido que nombra como su representante a su amigo Pedro. El médico que valora a la paciente en Urgencias y ha leído la directriz anticipada plantea a Pedro sus dudas sobre la misma, ya que el cuadro es agudo y potencialmente reversible tras tratamiento que incluye la ventilación mecánica, y parece que el documento está redactado pensando en una situación crónica, no en la actual. Usted considera CIERTO que:

1. El representante puede cambiar la directriz anticipada de la paciente, en su mejor interés.
2. El médico por ser una situación de urgencia no está obligado a seguir la directriz anticipada ni consultar con el representante.
3. El representante no puede cambiar la directriz anticipada. Su finalidad es garantizar el respeto a los valores de la paciente y el cumplimiento de la instrucción.
4. Los familiares directos presentes pueden hacer una decisión de sustitución en su mejor interés, no importando la opinión del representante.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

A través de las instrucciones previas se pretende situar al paciente en el centro de las decisiones sobre su atención sanitaria; con ellas se intenta respetar sus valores y preferencias y evitar medidas desproporcionadas, lo que también disminuye gastos sanitarios innecesarios en el final de la vida. Las decisiones incluidas en los documentos de instrucciones previas son vinculantes (respuesta 3 correcta), y pueden incluir tanto medidas positivas (qué hacer o qué medidas llevar a cabo, por ejemplo, pautar

tratamiento paliativo) como negativas (qué no se debe hacer, por ejemplo, mantener la vida artificialmente y por tanto retirar el soporte vital).

Paciente de 15 años, afecta de una leucemia mieloide aguda de reciente diagnóstico, que presenta unos niveles de hemoglobina de 4,4 g/dL. El médico de guardia que valora la analítica indica que la paciente debe recibir una transfusión sanguínea de forma preferente, pero las convicciones religiosas de la paciente y de su familia le impiden recibir dicho tratamiento. El médico debe:

1. Contactar con el juez de guardia para ponerle en conocimiento de la situación y que ordene la realización del tratamiento.
2. Abstenerse de realizar la transfusión e iniciar una sedación paliativa para que la paciente no sufra.
3. Proceder a realizar la transfusión a pesar de la negativa de la paciente y de sus padres.
4. Engañar a la paciente y a su familia diciéndoles que va a realizar un tratamiento distinto. Y proceder con la transfusión.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Según el artículo 31 del código deontológico, el médico nunca dejará de prestar asistencia al paciente que lo necesite por intento de suicidio, huelga de hambre o rechazo al tratamiento. Por otro lado, según la reforma de la Ley de Autonomía (vigente desde marzo de 2016), en el artículo 9.6 se especifica que: “En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho” (como es el caso de los menores de 18 años en caso de grave riesgo para su salud) [...] “la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad”. Por tanto, en los menores de 18 años con grave riesgo para su salud, prevalece el mayor beneficio para la vida o salud del paciente y, si es posible y da tiempo para ello (como es el caso que se plantea), se debe contar con autorización judicial para actuar (respuesta 1 correcta).

Mujer de 80 años que ingresa en el hospital para estudio de anemia tras ser llevada por sus hijos a Urgencias por rectorragia y decaimiento físico. Clínicamente se encuentra estable. Está diagnosticada de deterioro cognitivo, con ideación y juicio frecuentemente incoherentes y alteraciones conductuales, para lo que toma risperidona. Se sospecha neoplasia maligna de colon y se plantea realizar una colonoscopia. Usted verifica que la paciente es incapaz de entender adecuadamente lo que se le explica sobre tal prueba, su naturaleza, objetivos, posibles complicaciones o sus consecuencias diagnósticas y eventualmente terapéuticas. A este respecto, señale la afirmación CORRECTA:

1. Queda relevado de presentar un consentimiento informado a la paciente y se considera suficiente su criterio como médico para que se realice la colonoscopia.
2. Solicita la comparecencia del juez para que autorice la prueba, ante la incapacidad intelectual de la enferma para decidir convenientemente por sí misma.

3. Por no tener capacidad para decidir, deben hacerlo por ella sus familiares, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de la colonoscopia en el impreso de consentimiento informado.
4. Es jurídicamente aceptable un acuerdo entre el médico y los familiares de la enferma basado en un consentimiento informado verbal para que se practique la colonoscopia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El consentimiento informado es el acto de elección libre y sin coacción realizado por una persona dotada de capacidad y bien informada. Para que se produzca el consentimiento informado se ha de establecer un proceso comunicativo y deliberativo entre el profesional sanitario y el paciente, donde ambos toman conjuntamente las decisiones sobre la manera más adecuada de abordar el problema concreto de salud. El derecho al consentimiento informado obliga a los profesionales sanitarios a informar al paciente de todo aquello que pueda ser relevante en su proceso de toma de decisiones. Tras ello, para que el paciente pueda elegir, debe ejercer su voluntad en libertad y en pleno uso de sus facultades mentales. No obstante, el consentimiento informado tiene sus límites y excepciones. Una de ellas es el consentimiento por representación, el cual se puede llevar a cabo:

- 1) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas (familiares, en el caso de la pregunta) (respuesta 3 correcta).
- 2) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente.
- 3) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. El consentimiento lo dará el representante legal, después de haber escuchado su opinión.

-----O-----

Son excepciones al consentimiento informado todas las siguientes EXCEPTO una. Señálela:

1. Imperativo legal por riesgo para la salud pública.
2. Paciente incapacitado legalmente.
3. Situaciones de máxima urgencia.
4. Convicciones religiosas del paciente.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Las convicciones religiosas individuales no eximen de la cumplimentación del consentimiento informado. El resto de opciones son correctas.

-----O-----

Con respecto a la capacidad en Sanidad, es FALSO que:

1. Se adquiere en general a los 18 años.
2. Se adquiere en general a los 16 años.
3. Se adquiere a los 18 años para situaciones de riesgo grave.
4. En menores de 18 en situaciones de riesgo grave, los que deciden son los tutores o responsables.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La capacidad de obrar en sanidad es un término jurídico. Adquiere graduaciones: 16 años en general se considera mayoría de edad en Sanidad (opción 1 falsa, por lo que la marcamos). En situaciones de riesgo grave se considera capaz a partir de los 18 años. Las decisiones que implican gravedad en los menores de 18 son tomadas por sus tutores o responsables.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes principios NO pertenece a los principios básicos de la bioética propuestos por Beauchamp y Childress?

1. No maleficencia.
2. Igualdad.
3. Autonomía.
4. Beneficencia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta básica que intenta confundirnos con el concepto de igualdad y justicia. El principio de igualdad no es uno de los principios básicos de la bioética propuestos por Beauchamp y Childress (marcamos la opción de respuesta 2).

-----O-----

Paciente de 17 años, afecta de una leucemia mieloide aguda de reciente diagnóstico, que acude a Urgencias con muy mal estado general, presentando unos niveles de hemoglobina de 3,9 g/dL. El médico de guardia que valora al paciente indica que la paciente debe recibir una transfusión sanguínea de forma emergente, aunque las convicciones religiosas de esta paciente y de su familia le impiden recibir dicho tratamiento. Señale la actitud MÁS adecuada por parte del médico:

1. Proceder a realizar la transfusión a pesar de la negativa de la paciente y de sus padres y poner el caso en conocimiento del juez.
2. Contactar con el juez de guardia para ponerle en conocimiento de la situación y que ordene la realización del tratamiento.
3. Abstenerse de realizar la transfusión e iniciar una sedación paliativa para que la paciente no sufra.
4. Intentar persuadir al paciente y a su familia de que reciba la transfusión.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Según el artículo 31 del código deontológico, el médico nunca dejará de prestar asistencia al paciente que lo necesite por intento de suicidio, huelga de hambre o rechazo al tratamiento. En situaciones límites, previo requerimiento judicial, se aplicará la imprescindible asistencia médica, ya que la preservación de la vida prevalece sobre el principio de autonomía de la persona (según sentencia 121/1990 del Tribunal Constitucional). En este caso, ya que la necesidad de realización de la transfusión es emergente, lo apropiado es primero ayudar a la paciente y después debemos poner el caso en conocimiento del juez (respuesta 1 correcta).

-----O-----

El principio que implica abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros, se denomina:

1. Principio de justicia.
2. Principio de beneficencia.
3. Principio de no maleficencia.
4. Principio de no discriminación.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El principio de no maleficencia consiste en abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros (respuesta 3 correcta).

-----O-----

¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cuatro principios de la bioética propuestos por Beauchamp y Childress?

1. No maleficencia.
2. Confidencialidad.
3. Justicia.
4. Autonomía.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La confidencialidad no es uno de los principios de la bioética. El resto son ciertas y se complementarían con la beneficencia.

-----O-----

Mujer de 70 años que fue diagnosticada hace dos de un carcinoma lobulillar infiltrante de mama derecha estadio T2N2M1 (enfermedad ósea) de inicio que recibió cuatro ciclos de quimioterapia con taxotere y epirrubicina y posteriormente otras tres líneas diferentes de tratamiento por evidencia de progresión a nivel cutáneo y óseo. Ingresa con clínica de dolor en columna dorsal y se realiza RM que evidencia la presencia de una masa expansiva con compresión medular a nivel de T4 y T6. Inicia radioterapia paliativa y dexametasona sin mejoría del dolor y con agravamiento progresivo de la clínica con pérdida de fuerza en pierna izquierda. A la semana comienza con disnea, evidenciándose en Rx de tórax derrame pleural bilateral. Ante esta situación, la MEJOR actitud médica a seguir sería:

1. Informar al paciente (y a la familia si el paciente lo autoriza) del mal pronóstico a corto plazo y dar prioridad al control sintomático, planteando si es necesario la sedación paliativa.
2. Informar a la familia y prepararla para la fase de duelo, dado que nos encontramos ante una situación premortem.
3. Colocar tubo de tórax para toracocentesis y, si persiste la disnea asociada a agitación y angustia, plantear a la familia la conveniencia de sedación.
4. Descartar que la disnea se deba a insuficiencia respiratoria aguda por neumonía complicada y comenzar con el tratamiento antibiótico correspondiente.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La disnea es frecuente en las últimas horas de la vida y genera gran angustia en el paciente y su familia. En aquellos pacientes en los que se prevé el fallecimiento próximo, la sedación es una alternativa lícita cuando no se logra el control sintomático con otros procedimientos. Debe informarse al paciente y si es preciso (si el paciente lo autoriza o si no está en condiciones de tomar decisiones) a los familiares del pronóstico (respuesta 1 correcta).

-----o-----

Señale la afirmación FALSA respecto a la sedación paliativa:

1. No es preciso que el paciente presente síntomas refractarios.
2. Debe haber consentimiento explícito, implícito o delegado del paciente.
3. Los fármacos han de ponerse en las dosis y combinaciones requeridas.
4. Es la disminución o supresión del nivel de consciencia inducida por fármacos para conseguir un adecuado control sintomático.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Para que se pauté sedación terminal en un paciente con enfermedad terminal debe haber al menos un síntoma refractario. Los fármacos han de ponerse en dosis y combinaciones requeridas a la situación clínica para paliar el síntoma refractario.

-----o-----

Ante un paciente oncológico en cuidados paliativos que presenta anorexia, indique la medida terapéutica MENOS indicada:

1. Amitriptilina.
2. Medroxiprogesterona.
3. Dexametasona.
4. Acetato de megestrol.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La anorexia es la incapacidad del paciente para comer normalmente. La causa principal es la propia carga tumoral, pero también influyen el miedo al vómito, la saciedad precoz, disfunción autonómica, estreñimiento, dolor, fatiga, alteraciones en la boca, hipercalcemia, ansiedad, depresión y efectos secundarios del tratamiento. El tratamiento se basa en medidas generales, preparación adecuada de los alimentos, platos pequeños, raciones pequeñas, medidas farmacológicas, dexametasona, acetato de megestrol, medroxiprogesterona. La amitriptilina no tiene indicación, y se utiliza como coadyuvante en el dolor de tipo neuropático (marcamos la opción de respuesta 1).

-----o-----

Juan, residente de segundo año, atiende en urgencias a Sofía, una muchacha de 15 años que, al parecer, se ha desmayado en la escuela, sin llegar a perder la consciencia. La paciente cuenta que estaba pendiente de realizar un examen, lo que le causaba mucha ansiedad. Por el interrogatorio, parece entreverse una situación de cierto acoso por

parte de sus compañeros y la posibilidad de que sufra un trastorno alimentario. Las constantes vitales y la exploración neurológica son normales. Juan mantiene a Sofía en observación a la espera de que sus padres acudan al servicio, echando periódicamente una ojeada para comprobar cómo se encuentra la paciente. Tras el susto inicial, la paciente parece encontrarse cada vez mas animada y es muy simpática. En una ocasión, Juan la encuentra chateando activamente con su móvil. Juan le indica que sería mejor que dejase el móvil y descansase y, para tranquilizarla, le cuenta que él también utiliza mucho las redes sociales desde la facultad. Sofía pide perdón por desconocer que tenía que tener el móvil apagado y, tras apagarlo, le pregunta si podría hacerle una solicitud de amistad en Facebook. ¿Cuál cree que es la mejor respuesta de Juan?

1. Decirle que haga la solicitud de amistad y que la aceptará, pues está seguro de que en su página no hay elementos inapropiados para una chica de la edad de Sofía.
2. Dado que considera a Sofía una paciente vulnerable y le preocupa que pueda interpretar mal un rechazo, aceptar que haga la solicitud, pero solamente permitirle el acceso a determinados contenidos de su página.
3. Contestarle que es importante mantener unos ciertos límites profesionales entre pacientes y facultativos y que, desafortunadamente, si hace la petición, no podrá aceptarla, por lo que es mejor que no la haga.
4. Decirle que haga la petición, pero sin intención de aceptarla.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La actitud correcta a tomar en esta situación consistiría en marcar los límites de la relación médico-paciente de manera respetuosa (respuesta 3 correcta). El resto de respuestas son incorrectas.

-----o-----

La exigencia que obliga a que las determinaciones diagnósticas y terapéuticas que se tomen con los pacientes respeten escrupulosamente el balance riesgo-beneficio (siendo mayor el beneficio que los posibles riesgos y daños) y que además estén avaladas por la evidencia clínica. ¿A qué principio bioético corresponde esta afirmación?

1. Autonomía.
2. No maleficencia.
3. Beneficencia.
4. Justicia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta cuyo enunciado es exactamente la definición principio bioético de no maleficencia (respuesta 2 correcta).

-----o-----

Con respecto a la información que recuerda el paciente de la que le trasmite el médico, es CIERTO que:

1. El material que se presenta primero es el mejor recordado.
2. El recuerdo del paciente coincide con la información real transmitida por el médico.
3. Es esencial ser meticuloso para detallar las posibles cuestiones técnicas que puedan surgir a lo largo del proceso de tratamiento (como, por ejemplo, efectos secundarios de tratamiento) en la primera visita.
4. Cuanto más alto es el nivel intelectual del médico peor es lo que recuerda el paciente.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El material que se presenta primero es el mejor recordado (respuesta 1 correcta). En términos coloquiales, la información que llega primero y la que llega última es más recordable, mientras que el mensaje del medio es fácilmente olvidado; esto también se conoce como "efecto de posición serial".

-----o-----

Paciente de 80 años con EPOC severa y oxígeno a domicilio, que ingresa en el hospital para estudio de pérdida de peso y deterioro general. La Historia Clínica se realiza fundamentalmente a través de los hijos, ya que el paciente es muy poco comunicativo y además parece presentar cierto deterioro cognitivo, con una puntuación de 26 en el Minimental Test. Tras las pruebas realizadas, existe una sospecha justificada de cáncer de colon, por lo que habla con los hijos para tomar la decisión sobre realizar una colonoscopia. Uno de los hijos dice que "por supuesto, hay que hacer todo por papá", mientras que otro hijo, médico, tiene sus dudas, argumentando que "de todas formas no se le va a operar tal y como está". Las otras dos hijas tienen también dudas, aunque son más proclives a realizar la colonoscopia. A lo largo del ingreso el paciente se ha deteriorado. Usted verifica que es incapaz de entender adecuadamente lo que se le explica sobre la colonoscopia, su naturaleza, objetivos, posibles complicaciones o sus consecuencias. ¿Qué debe hacer ante esta situación?

1. Exponer el caso en la sesión de cáncer de colon para saber si en la situación actual al paciente se le trataría del cáncer de colon e informar a la familia de lo que se haya acordado en dicha sesión.
2. Realizar la colonoscopia, ya que es prioritario establecer un diagnóstico. Si es preciso solicitar autorización judicial.
3. Hacer caso del hijo médico ya que seguro que sabe mucho mejor que los otros hijos qué es lo mejor para su padre.
4. Consultar al Comité de Ética, ya que sus decisiones son vinculantes.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Antes de someter a un paciente con una patología grave y/o con mala calidad de vida a una medida invasiva, debemos determinar si dicha medida realmente será beneficiosa para dicho paciente. En este caso, es fundamental saber si el paciente va a ser tratado activamente (cirugía, QT, etc.) en caso de llegar al diagnóstico (respuesta 1 correcta). Si no es así, hay que reconsiderar realizar la colonoscopia.

-----o-----

Paciente de 54 años, competente y capaz, diagnosticado de VIH con carga indetectable, que acude a su médico de Atención Primaria debido a un cuadro progresivo de pérdida

de peso de 11 kg en los diez últimos meses, así como dolor abdominal y síndrome depresivo. Se le realiza una TC abdominal que evidencia la presencia de una masa de 3 cm en el proceso uncinado. No se observan adenopatías locorregionales significativas ni otras lesiones sugerentes de afectación metastásica. Se le realiza una biopsia guiada por ecografía que confirma la presencia de un adenocarcinoma acinar. Tras presentar el caso en un comité multidisciplinar, se decide la realización de duodenopancreatectomía cefálica. El paciente rechaza de forma vehemente cualquier tipo de intervención quirúrgica, así como el tratamiento farmacológico. A este respecto, señale la opción más adecuada en esta situación:

1. Aceptar la decisión del paciente y citarlo nuevamente para revisión en una semana.
2. Descartar la intervención quirúrgica y el tratamiento sistémico e iniciar tratamiento con radioterapia sobre la lesión.
3. Poner el caso en conocimiento de su familia para que autoricen la intervención.
4. Remitir al paciente a la Unidad de Cuidados Paliativos para realizar un adecuado tratamiento sintomático.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sobre un rechazo al tratamiento en un paciente capaz y competente. Lo ideal es realizar una comunicación persuasiva: se debe argumentar y aconsejar con sinceridad, evitando actitudes profesionales pasivas y acriticas. Con la persuasión se intenta que el paciente reconsidere la negativa al tratamiento. En muchos casos puede ser eficaz reevaluar al paciente en un corto período de tiempo para volver a plantear la situación e intentar convencerle (respuesta 1 correcta).

-----O-----

Ante un paciente con un carcinoma en base de lengua con metástasis ganglionares múltiples bilaterales y pulmonares, en tratamiento paliativo con quimioterapia sistémica, que presenta una mucositis orofaríngea grado 4, indique cuál de las siguientes actitudes le parece MÁS adecuada para garantizar un aporte diario adecuado de nutrientes:

1. Alimentación parenteral a través de vía venosa periférica.
2. Alimentación enteral a través de vía venosa central.
3. Alimentación parenteral a través de vía venosa yugular externa derecha.
4. Alimentación enteral a través de vía venosa periférica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La alimentación parenteral se utiliza en pacientes en los que, por alteraciones del tipo digestivo, no es posible una ingesta directa (mucositis, fistulas, etc.). El acceso es la vía venosa central, yugular externa o subclavia. Las soluciones contienen aminoácidos, glucosa, lípidos, vitaminas, minerales, oligoelementos y agua. Su administración requiere un control hidroelectrolítico riguroso.

-----O-----

Un hombre de 80 años es llevado a Urgencias por la policía al encontrarle por la noche,

en la calle, a varios bloques de su domicilio, algo perdido. Dice al médico de urgencias: “Me encuentro bien; estaba paseando y me he perdido”. La revisión por sistemas es anodina. Al preguntarle por medicaciones, no recuerda. En su historial constan glipizida, atenolol y acenocumarol. Ha estado tres veces en urgencias en los últimos tres meses por “mareo”, dolor lumbar y un INR de 5,0. Refiere independencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. No hay evidencias de familiares o amigos cercanos. Varias referencias del trabajo social del área indican que rechaza ayudas o visitas médicas o de enfermería. En la exploración física, únicamente destaca temperatura de 37,7 °C; IMC de 16 kg/m²; PA 160/90 mmHg; frecuencia cardíaca de 90 lpm y saturación de oxígeno del 99%. Tiene pérdida global de masa muscular. Está vestido con la bata de casa y huele a orina. Rechaza contestar a las preguntas del Mini-Mental. En las pruebas de laboratorio, destaca: leucocitos 13.000/microL, glucemia 300 mg/dL, hemoglobina A1c 11%, INR 0,9. Orina: más de 50 leucocitos/campo y nitritos +. Urocultivo: > 100.000 colonias de bacilos gramnegativos. Es ingresado en el hospital, recibe antibióticos, insulina y se reinicia acenocumarol con buena evolución. Está estable y quiere irse a su domicilio. La enfermera de planta refiere que es incapaz de autoadministrarse la insulina. ¿Cuál de los siguientes es el próximo paso para determinar la seguridad del paciente en su domicilio?

1. Referir a Atención Primaria y trabajo social del área para determinar la seguridad en el domicilio.
2. Evaluación formal de la capacidad para tomar decisiones concernientes a su salud.
3. Evaluación para descartar demencia.
4. Evaluación para descartar depresión.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un caso de un paciente con un posible deterioro cognitivo no diagnosticado. Ante estas situaciones es imprescindible evaluar la capacidad volitiva del paciente, para discernir si es capaz de tomar decisiones sobre su salud y su persona (respuesta 2 correcta). Una vez determinado esto ya se proseguiría con el pertinente estudio (averiguar si la causa del cuadro de incapacidad se debe a patología neurológica, psiquiátrica, etc.), pero en ningún caso se le podría dar el alta (ni irse de alta voluntaria), hasta haber sido valorada su capacidad de toma de decisiones.

-----O-----

Paciente de 47 años que es diagnosticada de carcinoma lobulillar infiltrante de mama con metástasis suprarrenales y óseas. Tras ser informada de las opciones terapéuticas y su pronóstico, decide no someterse al tratamiento. Todas las siguientes actuaciones estarían indicadas, EXCEPTO:

1. Intentar convencerle de que se someta al tratamiento con argumentos sólidos y estructurados.
2. Poner el caso en conocimiento de su familia para que ellos le obliguen a someterse al tratamiento.
3. Respetar la decisión de la paciente de no recibir el tratamiento, aunque su pronóstico vital empeore a corto plazo.
4. Intentar buscar otras opciones terapéuticas que pudieran ser efectivas en este caso.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso en el que es fundamental respetar el principio de autonomía de la paciente. El médico debe intentar convencer al paciente con argumentos sólidos y estructurados, así como buscar otras posibles opciones que pudieran ser útiles en este caso, pero en ningún momento debe obligar al propio paciente o intentar que sus familiares le obliguen a someterse al tratamiento, lo que vulneraría el principio de autonomía (marcamos la opción de respuesta 2).

-----O-----

Entramos en la habitación de Pilar, mujer de 92 años diagnosticada de demencia leve. No está incapacitada legalmente y es independiente. Ha ingresado con una sospecha de cáncer de pulmón, por lo que habría que hacerle una TC y probablemente una broncoscopia. Mantiene sin problema una conversación y está orientada. Está en la habitación con su hija. A la hora de dar la información y decidir la actitud a tomar sobre las pruebas a realizar:

1. Informaremos a su hija y que sea ella quien informe a la paciente, pues es quien mejor la conoce y sabe cómo reaccionará.
2. Debemos dar la información a la paciente, de acuerdo a la capacidad de comprensión.
3. Como médicos responsables de la paciente, sabemos cuál es el mejor tratamiento. Dado que la paciente no es capaz de comprenderlo, la decisión es exclusivamente nuestra.
4. Ya hablamos con su hija ayer y decidimos ocultarle la sospecha diagnóstica para que no sufriera, así que no le daremos más información, independientemente de lo que ella nos pregunte.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Los pacientes, de acuerdo con su capacidad cognitiva, tienen derecho a conocer toda la información disponible respecto a cualquier actuación en el ámbito de su salud y será el médico responsable del paciente quien garantice el cumplimiento de dicho derecho. Aunque una persona tenga reducida la competencia, debe ser informada y se le debe hacer partícipe de la toma de decisiones. Los médicos por tanto están obligados a dar al paciente toda la información relevante sobre su problema clínico. La información clínica formará parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades.

-----O-----

Una de las siguientes funciones no es competencia de los comités de ética para la investigación, señálela:

1. Aprobación de estudios farmacoepidémicos
2. Valoración y aprobación de estudios post-autorización
3. Evaluar la privacidad de los sujetos implicados en un ensayo.
4. Resolución de conflictos profesionales en el contexto de la realización de un ensayo clínico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La resolución de conflictos profesionales no es competencia de los comités de ética para la investigación.
El resto de opciones son correctas.

Un paciente de 59 años, acude a su consulta de atención primaria con un cuadro de dolor abdominal y estreñimiento. Se realiza una ecografía abdominal y colonoscopia. Se observa una masa en ciego que corresponde a un adenocarcinoma de colona. Señale cuál es la actitud más adecuada:

1. Informar al paciente de su diagnóstico si éste lo desea, intentando resolver sus dudas iniciales sobre la enfermedad y el proceso de tratamiento.
2. Derivar al paciente a una consulta de oncología para que le comuniquen el diagnóstico y todo lo que necesite saber acerca de la enfermedad y del tratamiento.
3. No decirle la verdad acerca del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, evitando la palabra cáncer la explicación.
4. Preguntar a la familia si quieren que el paciente conozca su diagnóstico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Ante un nuevo diagnóstico de cáncer debemos explicar rigurosamente todo lo que el paciente desee y necesite conocer sobre la enfermedad y las actitudes terapéuticas. La respuesta 2 no se puede considerar correcta de inicio, ya que no se debe demorar la comunicación sobre el diagnóstico a que el paciente acuda a la consulta de oncología, ya que esto genera una gran ansiedad en los pacientes, el médico de atención primaria debe intentar responder las dudas iniciales del paciente, siempre acorde a sus conocimientos sobre una materia determinada.

Con respecto a la doctrina actual del derecho respecto a los casos de rechazo, señale la afirmación CORRECTA:

1. El respeto a la decisión del médico es el criterio jurídico fundamental, puesto que siempre pretende un beneficio del paciente.
2. La decisión del paciente está por encima de la decisión del médico en toda situación, incluyendo las situaciones de riesgo vital, solamente cuando el paciente sea perfectamente capaz de tomar la decisión y en ausencia de imposiciones externas.
3. La decisión del paciente y por tanto el respeto a su autonomía es el principio jurídico fundamental. Se deberá respetar la decisión del paciente en todos los casos, aunque no esté probada su perfecta capacidad para tomar decisiones.
4. El respeto a la autonomía del paciente es el principio jurídico fundamental y hay que respetar siempre las decisiones de rechazo excepto en situaciones de riesgo vital.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Diferentes sentencias del tribunal constitucional establecen que el derecho a la vida o a la protección de la salud, a pesar de ser derechos protegidos por la Constitución, no son superiores a la libertad de elegir por parte del paciente, por lo que no se pueden imponer, por parte de los poderes públicos, medidas dirigidas a

proteger la vida en contra de la libre voluntad del paciente si este no tiene ninguna merma en su capacidad de tomar decisiones (respuesta 2 correcta).

-----o-----

Un paciente acude a Urgencias debido a un cuadro de hematemesis. Es ingresado para una observación y la realización de una gastroscopia diagnóstica al día siguiente. Cuando el paciente llega a la sala de endoscopias, se niega a someterse a la prueba. Señale la opción CORRECTA:

1. Respetar la decisión del paciente, pero intentar convencerlo de que reconsidere esta decisión.
2. El paciente puede tener cáncer no diagnosticado, con lo que se procederá a realizar la prueba bajo anestesia general.
3. Poner el caso en conocimiento del juez de guardia para que el paciente se someta a la prueba bajo imperativo judicial.
4. Dar de alta al paciente inmediatamente.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El paciente tiene el derecho a negarse a recibir un tratamiento, pero debe asegurarse que está bien informado (respuesta 1 correcta).

-----o-----

¿Cuánto dura la obligación de secreto profesional?

1. Toda la vida del paciente.
2. Toda la vida laboral del profesional sanitario.
3. Toda la vida del profesional sanitario.
4. Mientras al paciente no se le dé el alta hospitalaria.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La obligación de secreto profesional dura toda la vida del profesional sanitario.

-----o-----

Varón de 71 años, fumador y bebedor habitual, que hace seis meses fue diagnosticado de carcinoma epidermoide supraglótico estadio T3 N3 M0 tras la cirugía. Sigue revisiones mensuales en el Servicio de Otorrinolaringología, en la última de las cuales el paciente refiere hemoptisis por el orificio de la traqueostomía. Los estudios de imagen confirman la presencia de recidiva local con masa vegetante, ulcerada y sangrante. Se procede al ingreso del paciente para control sintomático y se presenta el caso en el comité de tumores del hospital, decidiéndose tratamiento mediante radioterapia con intención paliativa. A las 24 horas del inicio del mismo, comienza con

sangrado incoercible que le genera gran ansiedad. ¿Qué medida debería adoptar el médico de guardia del Servicio de Oncología?

1. Expansores de plasma y transfusión de varios concentrados de hematíes tamponando la zona de sangrado.
2. Si permanece consciente, hablar con el paciente y plantearle iniciar sedación con midazolam para control sintomático.
3. Intentar una sesión urgente de radioterapia para frenar el sangrado.
4. Taponamiento del traqueostoma y si persiste la hemorragia meter al paciente en quirófano para cirugía paliativa urgente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La hemorragia masiva puede ser el evento final en tumores del aparato respiratorio. Si el paciente está consciente suele ser una situación muy impactante tanto para él como para su familia, por lo que es necesario, tras hablar con el paciente, plantear el inicio de una sedación con 5-10 mg i.v. o 10-20 mg s.c. de midazolam (respuesta 2 correcta). No debes olvidar que para realizar una sedación paliativa deberíamos contar con el consentimiento del paciente. Si no puede dar el consentimiento porque en ese momento no es competente, se debería obtener el "consentimiento delegado" de sus allegados (de sus representantes). Solo en caso de no poder obtener el consentimiento por ninguna de estas vías podríamos actuar sin el consentimiento del paciente o de los allegados con una sedación paliativa.

-----O-----

Señale la respuesta CORRECTA en relación con los comités de ética para la asistencia sanitaria:

1. Dan recomendaciones respecto a cómo tiene que hacerse la investigación con seres humanos.
2. "Los comités de ética asistencial median, apoyan y hacen recomendaciones sobre los aspectos y conflictos éticos de la asistencia sanitaria."
3. "Regulan especialmente los ensayos clínicos. "
4. Se sitúan en la consejería de Sanidad específica para cada autonomía.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los CEAS no revisan la investigación con seres humanos: aconsejan ante posibles conflictos éticos en la práctica asistencial

-----O-----

¿Qué profesional sanitario tiene la obligación de prestar un socorro inmediato y urgente?

1. El que se encuentre prestando servicios profesionales en esos momentos
2. Sólo los médicos
3. Los médicos especializados en la atención que la situación requiere
4. Cualquier profesional sanitario

Resp. Correcta: 4

Comentario: Compromete a todo profesional sanitario como persona indicada para prestar un socorro inmediato y urgente

-----o-----

El consentimiento informado se obtiene por escrito en la mayoría de las intervenciones diagnósticas o terapéuticas llevadas a cabo en un centro sanitario, con algunas excepciones. Todas las siguientes situaciones están exentas de obtener el documento por escrito por parte del paciente, excepto una:

1. Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
2. Cuando el paciente voluntariamente se presta a la donación de embriones.
3. Cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas allegadas a él.
4. Cuando la urgencia no permita demoras por poder ocasionar lesiones irreversible o existir peligro de fallecimiento.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Se pregunta cuándo no es necesario que el propio paciente tenga que firmar el consentimiento escrito.

-----o-----

De los siguientes fármacos quimioterápicos, indique cuál tiene un MAYOR potencial emético:

1. Docetaxel.
2. Cisplatino.
3. Carboplatino.
4. 5-Fluorouracilo.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El cisplatino es un derivado del platino utilizado en el tratamiento de múltiples patologías oncológicas (cervix, faringe, etc.), y de entre todas las opciones es el que presenta un mayor potencial emético.

-----o-----

El establecer una comunicación abierta con el enfermo en situación terminal es para los profesionales sanitarios un escollo difícil de salvar en la práctica diaria. Con relación a la comunicación médico-paciente en esta situación, una de las siguientes afirmaciones NO es correcta. Señálela:

1. El 93% de la comunicación es no verbal.
2. La actitud de escucha adecuada es de pie al lado de la cama del enfermo.
3. La comunicación de la verdad no se alcanza en una sola entrevista, sino en múltiples.
4. La honestidad del mensaje nunca debe cambiarse para mejorar su aceptación.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La actitud de escucha adecuada es sentado al lado o en la cama del enfermo, nunca de pie y nunca con los brazos cruzados (opción 2 incorrecta, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

La agonía es el estado que precede a la muerte en el contexto de un deterioro progresivo en el paciente terminal. Solo uno de los siguientes signos y síntomas pueden formar parte del contexto clínico del paciente en dicha situación, señálelo:

1. Capacidad deglutoria conservada para la administración oral de medicación y suplementos.
2. Función esfinteriana y motilidad conservadas.
3. Evidencia o percepción de la realidad de la situación alterada.
4. Alteración del nivel de conciencia y desorientación.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El enfermo en fase de agonía presenta disminución del nivel de conciencia, aunque tiene percepciones de la realidad (Respuesta 4 correcta, respuesta 3 falsa), por lo que es posible comunicarse con él y preguntarle sobre su confort o problemas que pueda manifestar. Es habitual la utilización de comunicación no verbal, indicando a la familia que eviten hacer comentarios inapropiados en presencia del paciente. La función esfinteriana y la capacidad deglutoria están alteradas.

-----O-----

Paciente de 80 años en situación terminal que presenta dolores lancinantes en extremidad inferior derecha siguiendo el dermatoma de L5. El paciente solo responde parcialmente al tratamiento con morfina oral. Indique cuál de las siguientes actitudes le parece MÁS adecuada para mejorar su sintomatología:

1. Morfina intravenosa.
2. Gabapentina.
3. Fentanilo transdérmico.
4. Codeína.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El dolor neuropático lancinante no suele responder a los opioides y en estos casos es necesario añadir un tratamiento con un antiepiléptico como la gabapentina, fenitoína, pregabalina o carbamazepina (respuesta 2 correcta).

-----O-----

A la hora de atender pacientes en situaciones graves y complejas, ¿cuáles son las dos actitudes esenciales para una buena relación médico-paciente?

1. Demostrar buenos conocimientos y asertividad.
2. Tenacidad y constancia.
3. Empatía y compasión.
4. Seguridad y destreza.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta extraña sobre la relación médico-paciente, en la que nos piden que indiquemos las dos actitudes esenciales para una buena relación médico-paciente. Las respuestas 1,2 y 4 hacen referencia a habilidades cognitivas y laborales, mientras que la 3(opción 3 correcta) hace referencia a habilidades emocionales. Es necesario recordar que para una adecuada relación médico-paciente es necesario ser capaz de ponerse en el lugar del paciente.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes sistemas de prescripción terapéutica le parece el MÁS adecuado para evitar errores en el tratamiento del paciente hospitalizado?

1. Informar directamente a la enfermera de más confianza.
2. Escribir de puño y letra todos los pormenores del tratamiento.
3. Dictar el tratamiento a la secretaria para que lo pase a la enfermera/o.
4. Cumplimentar el registro de prescripción electrónica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El método más adecuado consistiría en registrarlo correctamente en el sistema de prescripción electrónica, de tal forma que quede constancia de ello (respuesta 4 correcta). También es importante comentárselo a la enfermera/o (puesto que no siempre pueden mirar las actualizaciones realizadas); sin olvidar que siempre debe quedar registrado en el sistema.

-----O-----

En cuanto a las complicaciones intercurrentes que pueden definir una situación de terminalidad en el seno de una demencia avanzada, es CIERTO que:

1. Generalmente la disfagia orofaríngea es un signo que aparece en fases tempranas de la enfermedad.
2. Las neumonías por mecanismo broncoaspirativo definen una situación de terminalidad desde su

primer episodio.

3. La aparición de úlceras por presión es consecuencia de una situación de inmovilidad, desnutrición y pérdida del autocuidado.
4. La desnutrición que aparece en la demencia avanzada frecuentemente mejora con suplementos dietéticos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las úlceras por presión son una complicación de origen multifactorial, y aparecen por la confluencia de inmovilidad, pérdida de autocuidado y desnutrición (respuesta 3 correcta). Repasemos las demás opciones de respuesta:

- 1.- Ninguna situación debe definirse como terminal por la aparición de un único episodio intercurrente de complicación.
- 2.- Las complicaciones más frecuentes en la demencia avanzada son de índole infecciosa, derivadas del síndrome confusional o asociadas a otros síndromes geriátricos clásicos.
- 4.- La desnutrición generalmente no responde al uso de suplementos.

-----O-----

Pasando visita médica, se percata de que el antibiótico intravenoso (amoxicilina-clavulánico) que había prescrito a su paciente se está administrando al otro paciente de la habitación en este mismo momento debido a un error de Enfermería. ¿Cómo actúa?

1. Le explica el problema al enfermero o la enfermera responsable para que detenga la infusión del fármaco y se la administre en su lugar a su paciente, y para que le explique el error a los pacientes.
2. Usted detiene la perfusión del fármaco y le explica al paciente al que se le estaba administrando que se le estaba infundiendo por error dicho fármaco, que se trata de un antibiótico.
3. Usted detiene la perfusión del fármaco y le explica al paciente al que se le estaba administrando que ya le había pasado dosis suficiente y que no necesita más.
4. Usted detiene la perfusión del fármaco y le explica al paciente el error si éste se lo pregunta, pero en caso contrario no realiza aclaraciones.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Si un profesional sanitario se percata de un error debe tratar de solucionarlo, y en este caso el médico puede solucionarlo sin necesidad de la presencia de la enfermera o el enfermero responsable. Por otra parte, se debe indicar al paciente que se trataba de un error; no se debe ocultar a los pacientes los errores que se cometen durante su cuidado.

-----O-----

Los principios de autonomía y beneficencia se incluyen en el concepto de:

1. Ética de mínimos.
2. Capacidad.
3. Ética de máximos.
4. Menor maduro.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los principios de autonomía y beneficencia forman parte de la ética de máximos.

-----O-----

Un paciente con diagnóstico de melanoma metastásico acude a Urgencias presentando intenso dolor en columna dorsal de 24 horas de evolución. A su llegada a Urgencias el paciente refiere sensación de parestesias en la cara anterolateral del miembro inferior izquierdo. Señale la actitud MÁS adecuada:

1. Administrar morfina y, si cede el dolor, hacer seguimiento domiciliario.
2. Realizar cirugía urgente.
3. Administrar dexametasona y solicitar una RMN urgente de columna dorsal.
4. Administrar dexametasona e iniciar radioterapia urgente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Lo más indicado sería administrar dexametasona y realizar una prueba de imagen que confirme la sospecha de síndrome de compresión medular (respuesta 3 correcta).

-----O-----

En la etapa final de la enfermedad terminal se produce un deterioro muy importante del estado general del enfermo, siendo un indicador fundamental de una muerte inminente. En relación al cuidado de los enfermos en fase agónica y al tratamiento de la sintomatología que puede aparecer, señale la opción falsa:

1. La posición más confortable para el enfermo suele ser el decúbito lateral con piernas flexionadas.
2. No es necesario el tratamiento específico de la fiebre si no crea problemas.
3. La vía de administración farmacológica de elección es la intravenosa.
4. No se debe prescindir del uso de narcóticos potentes aunque el paciente entre en coma.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La vía de elección en fase terminal de la enfermedad es la oral mientras sea posible. El resto de las opciones son correctas.

-----O-----

Para realizar un ensayo clínico y al finalizarlo, ¿A quién se eleva informe del mismo?

1. Al Comité de Bioética de España.
2. Al Comité de Ética de la Investigación Clínica.
3. Al Ministerio de Sanidad.
4. Al Comité de Ética Asistencial.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los Comités Éticos de Investigación Clínica. Desempeñarán las siguientes funciones:

- a) Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales de los ensayos clínicos que les sean remitidos.
- b) Evaluar las modificaciones relevantes de los ensayos clínicos autorizados.
- c) Realizar un seguimiento del ensayo, desde su inicio hasta la recepción del informe final.

-----o-----

¿Qué dos principios de la bioética están enfrentados en una situación de rechazo a las decisiones médicas?

- 1. Autonomía - No maleficencia.
- 2. Beneficencia - No maleficencia.
- 3. Beneficencia - Autonomía.
- 4. No maleficencia - Justicia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Clásicamente se considera que todo problema de rechazo es un conflicto de valor entre una decisión médica tomada en beneficio del paciente en el contexto de su situación clínica y tras sopesar la relación riesgo/beneficio, y lo que el paciente quiere o (en este caso) no quiere que se haga con su cuerpo (autonomía) (respuesta 3 correcta).

-----o-----

Las declaraciones legales que permiten a las personas articular valores y establecer preferencias terapéuticas que deberán ser respetadas en el futuro si pierden su capacidad se denominan:

- 1. Consentimiento informado
- 2. Directrices anticipadas
- 3. Capacidades legales
- 4. Principio de autonomía

Resp. Correcta: 2

Comentario: El enunciado corresponde a la definición de las directrices anticipadas.

-----o-----

Para que un ensayo de investigación sea ético tiene que reunir los siguientes requisitos excepto:

- 1. Razón riesgo/ beneficio favorable
- 2. Respeto a los sujetos inscritos con la posibilidad de permitirles salirse de la investigación
- 3. Que la selección de sujetos se haga cuidando de que no se seleccione a personas estigmatizadas para las investigaciones riesgosas, mientras que a las más favorecidas se les ofrezca participar en investigaciones de potencial más beneficioso

4. Evaluación del diseño del ensayo, la población sujeto propuesta y la razón riesgo/beneficio por individuos vinculados a la investigación.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La evaluación independiente es uno de los requisitos para que un ensayo de investigación sea ético. Debe ser realizada por sujetos AJENOS a la investigación. Por lo que la respuesta que hay que marcar es la 4.

La respuesta 3 hace referencia a la selección equitativa de los sujetos.

-----o-----

El psiquiatra de interconsulta acude a examinar a un paciente en Cardiología que rechaza un tratamiento que el facultativo a cargo del caso considera indicado e insustituible. Tras la exploración no aprecia patología psiquiátrica alguna; el paciente comprende la información que se le ha aportado, los posibles beneficios y riesgos del tratamiento (incluido el fallecimiento), y sopesa adecuada y racionalmente esta información, pero se mantiene firme en su decisión de no ser tratado. El psiquiatra concluye que el enfermo está capacitado para la toma de decisiones en el ámbito de la atención sanitaria. La enfermedad que presenta el paciente, que se niega a firmar el alta voluntaria, no es infecciosa ni representa ningún riesgo especial para terceros. ¿Cuál es la decisión más adecuada a tomar?

1. Ingreso en Psiquiatría para trabajar la negación y la rabia inherentes a su proceso.
2. Solicitar la intervención de familiares que autoricen la intervención.
3. Respetar la decisión del paciente y buscar las alternativas que haya disponibles para el caso.
4. Incapacitación civil.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La Ley de Autonomía del Paciente especifica claramente el derecho del paciente a rechazar un tratamiento. La valoración de la competencia para rechazar un tratamiento médico no es un tema específicamente psiquiátrico, aunque con frecuencia, en los hospitales, se acabe llamando al psiquiatra de guardia para que ayude a la hora de proceder con estas situaciones. El psiquiatra evaluará al paciente y determinará si existe o no alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica que altere la capacidad de comprender la información que se le haya ofrecido sobre su problema de salud, a la vez que determinará si dicha información es de la calidad suficiente para que el sujeto pueda valorar adecuadamente los riesgos de las distintas opciones. En el caso de que el paciente sea capaz de procesar la información de una forma adecuada y exprese su negativa a la intervención propuesta no se podrá actuar contra su voluntad salvo que la patología concreta que presente suponga un problema para la Salud Pública por el riesgo para terceras personas (p.ej. tuberculosis bacilífera o multirresistente). Otra excepción al derecho del paciente a rechazar un tratamiento son las situaciones de urgencia vital, en las que los médicos se vean forzados a actuar sin poder obtener previamente el consentimiento del paciente.

-----o-----

El síndrome de compresión medular es una patología frecuente en pacientes con procesos oncológicos avanzados. De las siguientes afirmaciones, indique la que NO es

correcta:

1. En el 90% de los casos existe dolor a nivel de la columna que aumenta con los movimientos y la tos, empeora con el decúbito y no suele ceder con analgesia habitual.
2. El 70% de las lesiones se localizan a nivel dorsal, el 20% a nivel lumbosacro y el 10% en segmentos cervicales.
3. El cáncer de próstata en los varones y el de mama en las mujeres son los tumores primarios que más frecuentemente producen este síndrome.
4. Entre el 8% y el 47% de los pacientes presentan compresión medular como primera manifestación clínica de su enfermedad.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El cáncer de pulmón en el varón es el tumor primario que más frecuentemente produce síndrome de compresión medular. El cáncer de próstata se sitúa en segundo lugar en los varones, seguido por linfomas, sarcomas, tumores renales, mielomas y tumores gastrointestinales.

-----o-----

En nuestro Sistema Nacional de Salud se procura que exista un Comité de Ética Asistencial. ¿En dónde?

1. En cada Sistema Sanitario de las Comunidades Autónomas.
2. En cada Centro Sanitario.
3. En cada Área de Salud.
4. En cada Hospital General.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En nuestro Sistema Nacional de Salud se procura que exista además un Comité de Ética Asistencia en cada Hospital General (respuesta 4 correcta).

-----o-----

En la comunicación médico-paciente, todas las siguientes afirmaciones son ciertas, EXCEPTO:

1. Mostar seguridad en las decisiones clínicas, para que el paciente las acate sin dudar.
2. Mostar empatía hacia el paciente y su familia.
3. Dedicar al paciente el tiempo que sea necesario hasta que nos aseguremos de que ha entendido perfectamente todo lo relativo a su proceso.
4. Realizar una explicación detallada de todos los aspectos relativos a la enfermedad y su tratamiento, siendo el paciente el que deba decidir acerca del mismo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El principio de autonomía defiende el derecho del paciente a ser informado de todo su proceso diagnóstico, terapéutico y pronóstico, siendo él mismo el que deba tomar la decisión final. El médico no debe imponer

sus decisiones clínicas sin tener la seguridad de que el paciente realmente ha comprendido todos los aspectos relativos a las mismas.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes situaciones NO supone un límite del consentimiento informado?

1. Si existe riesgo para la salud pública
2. Si existe riesgo inmediato para el paciente
3. Si el paciente tiene 16 años, ya que al ser menor de edad, la toma de decisiones la llevará a cabo su representante legal, siempre después de haber escuchado su opinión.
4. Si el paciente no se encuentra en plenas facultades para la toma de decisiones, en este caso, se otorgará el consentimiento por representación.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

(La minoría de edad establecida en el ámbito de la salud es de 16 años, por tanto, la respuesta tercera sería incorrecta)

-----O-----

Respecto a la información que recuerda el paciente de la que le trasmite el médico:

1. El material que se presenta primero es el mejor recordado.
2. El recuerdo del paciente coincide con la información real transmitida por el médico.
3. Es esencial ser meticuloso para detallar las posibles cuestiones técnicas que puedan surgir a lo largo del proceso de tratamiento (como por ejemplo, efectos secundarios de tratamiento) en la primera visita.
4. Cuanto más alto es el nivel intelectual del médico peor es lo que recuerda el paciente.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El material que se presenta primero al paciente es el mejor recordado, por esto el médico debe elegir cuidadosamente el orden de la presentación de la información.

-----O-----

El consentimiento informado tiene por objeto principal:

1. Liberar al médico de responsabilidad si surgen complicaciones.
2. Evitar demandas judiciales por cualquier vía.
3. Respetar el principio de autonomía.
4. Incluir al paciente en lista de espera quirúrgica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

-----O-----

Con respecto a los conceptos de coma y muerte encefálica, es INCORRECTO que:

1. La muerte encefálica, también llamada muerte cerebral, se define como el cese, completo pero irreversible de la actividad encefálica o cerebral.
2. Para el diagnóstico de muerte encefálica la aparente ausencia de función cerebral no es suficiente; se requieren varias pruebas de esa irreversibilidad.
3. La muerte encefálica supone la muerte del individuo, ya que se da una pérdida total e irreversible de las funciones cerebrales.
4. Cuando una persona está en coma, está muerto, ya que se da una pérdida de la conciencia sin actividad cerebral bioeléctrica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Cuando una persona está en coma, está viva, ya que hay una pérdida transitoria de la conciencia con actividad cerebral bioeléctrica (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son ciertas.

Los Comités de Ética Asistencial, ¿a quién orientan en sus decisiones?

1. A los profesionales sanitarios.
2. Al paciente.
3. A los familiares del paciente.
4. A todos los anteriores.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Un Comité de Ética Asistencial es un grupo multidisciplinar de personas que, dentro de una institución sanitaria, ha sido específicamente establecido para aconsejar a los profesionales sanitarios en sus decisiones sobre las cuestiones éticas planteadas en el curso de la práctica clínica.

El cuidado de la piel es importante tanto en la persona sana como en la enferma. En las fases finales de la vida las pequeñas alteraciones en la textura y resistencia de la piel son fundamentales a la hora de aumentar el riesgo de aparición de determinadas alteraciones de la misma. Una de las lesiones más importantes en estos enfermos son las úlceras de decúbito o por presión, que suelen estar provocadas por el encamamiento prolongado. De entre las siguientes opciones, señale la FALSA:

1. Cambios posturales cada 2-3 horas.
2. El paciente ha de estar siempre húmedo para garantizar la adecuada hidratación de la piel.
3. Se debe emplear jabón neutro para la higiene diaria.
4. Colocar un empapador entre el colchón y el paciente.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La humedad es responsable de la maceración de la piel. El paciente ha de estar siempre seco. Es importante colocar un empapador entre el colchón y el paciente para que absorba la humedad.

En la etapa final de la enfermedad terminal se produce un deterioro muy importante del estado general del enfermo, siendo un indicador fundamental de una muerte inminente. En relación al cuidado de los enfermos en fase agónica y al tratamiento de la sintomatología que puede aparecer, señale la opción FALSA:

1. La posición más confortable para el enfermo suele ser el decúbito lateral con piernas flexionadas.
2. No es necesario el tratamiento específico de la fiebre si no crea problemas.
3. La vía de administración farmacológica de elección es la subcutánea.
4. No se debe prescindir del uso de narcóticos potentes aunque el paciente entre en coma.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La vía de elección en fase terminal de la enfermedad es la oral, mientras sea posible. El resto de las opciones son correctas.

-----O-----

La exigencia que obliga a que las determinaciones diagnósticas y terapéuticas que se tomen con los pacientes respeten escrupulosamente el balance riesgo-beneficio y estén avaladas por la evidencia clínica, responde al principio bioético de:

1. Autonomía.
2. No maleficencia.
3. Beneficencia.
4. Justicia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Respeto a la autonomía

Respeto activo a la libertad de elección de la persona, no sólo absteniéndose de obstaculizarla, sino procurando que se den las condiciones necesarias para practicarla. Para ejercerla plenamente, el sujeto debe conservar las facultades mentales y tiene que ejercer con libertad su voluntad (sin coerción ni coacción externa). Se pone en práctica a través del consentimiento informado

Beneficencia

Obligación de actuar en beneficio del enfermo, ayudándole a promover sus legítimos intereses. Tras ser informado por el médico, el enfermo decide lo que es bueno para él dentro de las posibles alternativas

No maleficencia

No producir daños intencionadamente y evitar además los daños en la medida de lo posible, haciendo en cada decisión un balance del riesgo-daño vs beneficio

Justicia

Distribución equitativa entre todos los miembros de la sociedad de los recursos sanitarios, de los beneficios que ofrece el sistema sanitario y de las cargas precisas para mantenerlo (p. ej, impuestos)

-----O-----

Respecto a la actitud del médico en los casos de rechazo, señale la respuesta CORRECTA:

1. El médico tiene la obligación ética de intentar persuadir, convenciendo con razones al paciente, para que reconsidere su postura.
2. El médico, una vez respetada su decisión de rechazo, dará de alta al paciente sin obligación explorar tratamiento alternativos.
3. No es labor del médico, sino de las autoridades judiciales, investigar la posible existencia de coacciones externas por parte de la familia que determinen su decisión de rechazo.
4. El médico deberá aceptar sin más la decisión del paciente.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Antes de aceptar el rechazo, hay que dar argumentos e intentar convencer al paciente sobre qué es lo mas apropiado (sin manipular ni coaccionar).

-----O-----

Marca la afirmación INCORRECTA acerca del consentimiento informado:

1. Por norma general, es un documento escrito
2. Entre sus finalidades se encuentra la de otorgar protección jurídica a los profesionales sanitarios
3. Aún cuando el paciente tenga la capacidad modificada, debe ser él el que otorgue su consentimiento para un intervención, ya que al fin y al cabo es el máximo representante de la voluntad sobre su cuerpo.
4. Todas las anteriores

Resp. Correcta: 4

Comentario:

(Por normal general, es un documento VERBAL, se suministrará por escrito en los siguientes supuestos: intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, y en general, cualquier intervención que pueda suponer un riesgo potencial notorio sobre el paciente. Su finalidad es la de informar al paciente, NO la de otorgar protección jurídica al profesional que le atiende. La respuesta tercera también es falsa porque existen limitaciones al consentimiento informado, como lo es la capacidad modificada judicialmente.)

-----O-----

Paciente de 79 años, que acude por cuarta vez consecutiva a un Servicio de Urgencias debido a dolor en columna dorsal resistente a la analgesia habitual, con una puntuación EVA de 9. Se le realiza TC urgente de columna, en el que se evidencia una masa de partes blandas a nivel de D5-D6 que infiltra el espacio epidural sin aparente compresión medular. Ante dichos hallazgos y con el antecedente de hiperplasia benigna de próstata, se realiza una determinación de PSA con un valor de 1.027 ng/ml. ¿Cuál de las siguientes actitudes terapéuticas NO estaría indicada?

1. AINEs y opioides en combinación con fármacos coadyuvantes.
2. Radioterapia urgente.
3. Agonistas LHRH y antiandrógenos.
4. Vertebroplastia o cementación del cuerpo vertebral afecto.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los agonistas LHRH actúan inhibiendo el eje gonadal mediante un feedback negativo sobre el hipotálamo, lo que origina una elevación transitoria de los niveles de testosterona. No se deben administrar cuando existe riesgo de compresión medular porque pueden agravar la clínica.

-----O-----

El principio que implica tratar a cada paciente como corresponde, disminuyendo las situaciones de desigualdad, se denomina Principio de:

1. Igualdad.
2. Justicia.
3. Solidaridad.
4. No discriminación.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se debe tratar a cada uno como corresponde, disminuyendo las situaciones de desigualdad con un equitativo reparto de los recursos sanitarios, atendiendo a parámetros como las necesidades personales, capacidad económica, etc.

-----O-----

La comunicación en la práctica clínica tiene como objetivo PRIMORDIAL:

1. La gratificación profesional.
2. El avance científico.
3. Servir a las necesidades del paciente.
4. La exactitud diagnóstica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La comunicación es un acto fundamental en la práctica clínica y tiene como objetivo primario servir a las necesidades del paciente (respuesta 3 correcta). Una comunicación efectiva mejora la satisfacción del paciente, así como la comprensión y la adherencia a las estrategias terapéuticas implementadas. Las habilidades de comunicación constituyen uno de los elementos esenciales de la competencia clínica del profesional sanitario. El método central de la comunicación en la práctica clínica es la entrevista clínica, a través de la que se debe crear una buena relación profesional sanitario-paciente, donde el profesional debe aplicar tanto sus conocimientos técnicos como su humanidad para obtener la máxima confianza por parte del paciente.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta con respecto a los principios básicos de la Bioética?

1. Son las fuentes fundamentales a partir de las cuales justificamos las pautas para la acción, los deberes y las reglas.
2. La capacidad de comprensión y la falta de coerción externa son fundamentales a la hora del ejercicio

de la autonomía.

3. El principio de beneficencia y el de autonomía están relacionados y en ocasiones pueden entrar en conflicto.
4. El principio de justicia se refiere a la compensación debida a los pacientes por las posibles malas prácticas médicas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El principio de justicia se refiere a la distribución equitativa de recursos, beneficios y cargas entre todos los miembros de la sociedad (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos). El principio de justicia puede desdoblarse en dos: un principio formal (tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales) y un principio material (determinar las características relevantes para la distribución de los recursos sanitarios: necesidades personales, mérito, capacidad económica, esfuerzo personal, etc.). La política sanitaria se basa en el principio de justicia, y será tanto más justa en cuanto que consiga una mayor igualdad de oportunidades para compensar las desigualdades.

-----O-----

Si un profesional sanitario atiende a personas con enfermedades que puedan suponer un peligro para terceros:

1. Podrá denunciarlo a la autoridad competente.
2. Deberá denunciarlo a la autoridad competente.
3. Su obligación de secreto profesional le impide denunciarlo.
4. Solo está obligado denunciarlo si se trata de enfermedad grave.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Existen excepciones a la obligación del secreto profesional de los profesionales sanitarios, como las situaciones que puedan suponer un peligro para la salud pública o para terceras personas. A esto se le llama Estado de Necesidad en el Código Penal art. 20.5, que consiste en la vulneración de un derecho para evitar un mal mayor. Así, los profesionales sanitarios tienen la obligación de declarar los casos de enfermedades infectocontagiosas detalladas por la Autoridad Sanitaria, con fines epidemiológicos y de prevención.

-----O-----

Un paciente de 69 años, fumador, sin otros antecedentes de interés, acude a su consulta de atención primaria con un cuadro de tos, sin fiebre ni expectoración. Se realiza Rx de tórax donde se observa un opacificación completa del LSD. Tras dichos hallazgos, se realiza TC de tórax donde se observa tumoración broncogénica con adenopatías mediastínicas múltiples y metástasis hepáticas en ambos lóbulos. Posteriormente se somete a fibrobroncoscopia con toma de biopsia que confirma el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón. Señale cuál es la actitud más adecuada:

1. Informar al paciente de su diagnóstico si éste lo desea, intentando resolver sus dudas iniciales sobre la enfermedad y el proceso de tratamiento.
2. Derivar al paciente a una consulta de oncología para que le comuniquen el diagnóstico y todo lo que necesite saber acerca de la enfermedad y del tratamiento.
3. No decirle la verdad acerca del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, evitando la palabra cáncer

la explicación.

4. Preguntar a la familia si quieren que el paciente conozca su diagnóstico.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Informar al paciente acorde a su deseo de conocer sobre la enfermedad que padece, demostrando empatía con el enfermo, con un trato de calidad y calidez.

-----O-----

Uno de los siguientes principios NO es un objetivo de los cuidados paliativos. Señálelo:

1. El paciente debe recibir una atención integral, individualizada y continua.
2. El tratamiento se dirigirá al enfermo y a la familia.
3. Tomar decisiones terapéuticas por el paciente que garanticen su confort debido al deterioro de su estado general.
4. Tomar una actitud terapéutica activa en el tratamiento de los pacientes.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las decisiones terapéuticas siempre deben estar regidas por el fomento de la Autonomía y Dignidad del paciente, de modo que este debe participar en todas las decisiones que se lleven a cabo sobre su tratamiento.

-----O-----

En el paciente en cuidados paliativos con enfermedad terminal, indique cuál de las siguientes opciones NO es causa de confusión o delirio:

1. Metástasis cerebrales.
2. Demencia progresiva.
3. Encefalopatía por fallo orgánico.
4. Trastornos hidroelectrolíticos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La confusión o delirio se define como un proceso reversible, al contrario de lo que ocurre con la demencia, que es progresiva e irreversible, por lo que no se puede incluir la demencia como causa de confusión o delirio. Las dos patologías podrían coexistir en el mismo paciente.

-----O-----

En relación a la sedación paliativa, es CIERTO que:

1. El objetivo primordial es el control sintomático.
2. No es necesario un consentimiento por parte del paciente, explícito, implícito o delegado.
3. No es preciso que el paciente presente síntomas refractarios al tratamiento específico.
4. Disminuir el tiempo de agonía es uno de sus objetivos secundarios.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El objetivo fundamental de la sedación es realizar un control sintomático mediante la

disminución del nivel de conciencia ante la presencia de síntomas refractarios al tratamiento específico. Es necesario un consentimiento por parte del paciente o de su familia en caso de que sea delegado. Nunca persigue acelerar el proceso de muerte, aunque en algunas ocasiones sea un efecto colateral.

-----O-----

Con relación al dolor oncológico, una de las siguientes afirmaciones NO es correcta. Señálela:

1. La sensación de dolor es totalmente subjetiva y solo el paciente puede percibirla.
2. Las leucemias son los procesos neoplásicos que presentan una mayor prevalencia de dolor.
3. El dolor no debe ser contemplado como un síntoma aislado.
4. Entre los enfermos con cáncer avanzado, el 50% sufren dolor de moderado a severo, y un 30% muy severo o intolerable.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Las leucemias son los procesos neoplásicos con la menor frecuencia de dolor en relación con el resto de patologías.

-----O-----

Paciente que acude a Urgencias debido a un cuadro autolimitado de rectorragia franca. Es ingresado para observación y realización de una colonoscopia diagnóstica al día siguiente. Cuando el paciente llega a la sala de endoscopias, se niega a someterse a la prueba. Señale la afirmación CORRECTA:

1. Debemos intentar convencerle de la conveniencia de la colonoscopia. Si tras ello el paciente se mantiene en su decisión, se debe respetar la decisión del paciente, siendo necesario pensar en posibles alternativas.
2. El paciente puede tener cáncer no diagnosticado, por lo que se procederá a realizar la prueba bajo anestesia general.
3. Debemos poner el caso en conocimiento del juez de guardia para que el paciente se someta a la prueba bajo imperativo judicial.
4. Debemos dejar que el paciente se tranquilice e intentar realizar la prueba al día siguiente con la autorización de la familia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Según la Ley de Autonomía, el paciente puede rechazar un tratamiento o una prueba indicada si está capacitado para hacerlo. Los profesionales deben recomendarle que es lo mejor y si el paciente lo rechaza, los profesionales deben buscar y ofrecer las mejores alternativas disponibles (respuesta 1 correcta).

-----O-----

La bioética ha sido definida como “el estudio sistemático de las dimensiones, conductas y políticas, de las ciencias de la vida y de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un marco interdisciplinario”. Una de las siguientes afirmaciones sobre los principios legales de la bioética NO es correcta. Señálela:

1. La capacidad es la aptitud para gestionar y realizar los actos necesarios que sean decisivos para los

intereses de una persona. Nadie puede ser incapacitado sin una sentencia judicial.

2. El consentimiento informado se define como la decisión diagnóstica o terapéutica legalmente válida tomada voluntariamente por un paciente con capacidad y basada en la información sobre riesgos, beneficios y tratamientos alternativos, derivada de la comunicación con un profesional de la salud.
3. Las directrices anticipadas exigen que las determinaciones diagnóstico-terapéuticas que se tomen con los pacientes respeten escrupulosamente el balance riesgo-beneficio y estén avaladas por la evidencia científica.
4. La responsabilidad médica es la obligación moral y legal que tienen los médicos de satisfacer y reparar las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios, e incluso involuntarios, cometidos durante el ejercicio de su profesión.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las directrices anticipadas son declaraciones legales que permiten a las personas articular valores y establecer preferencias terapéuticas que deberán ser respetadas en el futuro si pierden su capacidad (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----o-----

El psiquiatra de interconsulta acude a examinar a un paciente en Cardiología que rechaza un tratamiento que el facultativo a cargo del caso considera indicado e insustituible. Tras la exploración no aprecia patología psiquiátrica alguna. El paciente comprende la información que se le ha aportado, los posibles beneficios y riesgos del tratamiento (incluido el fallecimiento), y sopesa adecuada y racionalmente esta información, pero se mantiene firme en su decisión de no ser tratado. El psiquiatra concluye que el enfermo está capacitado para la toma de decisiones en el ámbito de la atención sanitaria. La enfermedad que presenta el paciente, que se niega a firmar el alta voluntaria, no es infecciosa ni representa ningún riesgo especial para terceros. ¿Cuál es la decisión MÁS adecuada a tomar?

1. Ingreso en Psiquiatría para trabajar la negación y la rabia inherentes a su proceso.
2. Solicitar la intervención de familiares que autoricen la intervención.
3. Alta hospitalaria.
4. Informar al juez con el fin de que ordene tratamiento.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La Ley de Autonomía del Paciente especifica claramente el derecho del paciente a rechazar un tratamiento. La valoración de la competencia para rechazar un tratamiento médico no es un tema específicamente psiquiátrico, aunque con frecuencia, en los hospitales, se acabe llamando al psiquiatra de guardia para que ayude a la hora de proceder con estas situaciones. El psiquiatra evaluará al paciente y determinará si existe o no alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica que altere la capacidad de comprender la información que se le haya ofrecido sobre su problema de salud, a la vez que determinará si dicha información es de la calidad suficiente para que el sujeto pueda valorar adecuadamente los riesgos de las distintas opciones. En el caso de que el paciente sea capaz de procesar la información de una forma adecuada y exprese su negativa a la intervención propuesta, no se podrá actuar contra su voluntad salvo que la patología concreta que presente suponga un problema para la Salud Pública por el riesgo para terceras personas (como por ejemplo, tuberculosis bacilífera o multirresistente). Otra excepción al derecho del paciente a rechazar un tratamiento son las situaciones de urgencia vital, en las que los médicos se vean forzados a actuar sin poder obtener

previamente el consentimiento del paciente.

-----O-----

En cuál de los siguientes supuestos no es aplicable el principio de autonomía:

1. Paciente menor de edad, en situación de emancipación
2. Paciente mayor de edad, con máximo grado de incapacitación judicial
3. Paciente de 16 años, declarado competente por su médico de atención primaria
4. Paciente mayor de edad, con esquizofrenia paranoide, declarado competente por su psiquiatra habitual

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En el segundo supuesto el paciente tiene incapacitación legal máxima, con lo que no podrá ejercer plenamente el principio de autonomía. El resto de opciones son ciertas.

-----O-----

Un paciente con diagnóstico de melanoma metastásico acude a urgencias presentando intenso dolor en columna dorsal de 24 h de evolución. A su llegada a urgencias el paciente refiere sensación de parestesias en cara anterolateral del miembro inferior izquierdo. Señale la actitud más adecuada:

1. Administrar morfina y si cede el dolor hacer seguimiento domiciliario.
2. Realizar cirugía urgente.
3. Administrar dexametasona y solicitar una RM urgente de columna dorsal.
4. Administrar dexametasona e iniciar radioterapia urgente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La opción correcta es la 3:

Administrar dexametasona y solicitar una RM urgente de columna dorsal.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes opciones NO se engloba entre los cuidados de un paciente ante la muerte?

1. El acompañamiento físico de las personas
2. El mantenimiento y continuación de todos los tratamientos previos del paciente
3. El proporcionar confort o apoyo espiritual en caso necesario
4. El cuidado y atención a familiares y allegados a lo largo del proceso.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En el proceso de morir, igual que en cualquier otro momento de la vida de los pacientes, es esencial la revisión frecuente del tratamiento, para confirmar que se adecua al plan de cuidados general del paciente. Esta adecuación dinámica de medidas es parte esencial del cuidado médico del paciente

-----O-----

Pedro, un hombre de 42 años, consulta con su médico de familia para el control periódico de una hipertensión arterial diagnosticada hace dos años. El médico comprueba que el paciente es fumador de 15 cigarrillos/día y plantea como objetivo al paciente el abandono del hábito tabáquico. Pregunta al paciente si se ha planteado con anterioridad dejar de fumar, si lo ha conseguido y ha recaído en alguna ocasión. Después de escuchar los puntos de vista de Pedro en relación con el abandono del tabaco, identifica ambivalencias del paciente en relación a su conducta y negocia con él un plan para conseguir el objetivo planteado. La entrevista clínica realizada por el médico de familia se denomina:

1. Entrevista semiológica.
2. Entrevista informativa.
3. Entrevista motivacional.
4. Entrevista operativa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La opción de respuesta correcta es la 3, ya que nos encontramos ante un paciente fumador que acude a su médico de familia y se plantea el objetivo de abandonar el hábito tabáquico. Repasemos los distintos tipos de entrevista:

- Entrevista semiológica: Modalidad de entrevista en la que nos marcamos como objetivo establecer la presencia de unos síntomas o signos para los que se nos pide una orientación diagnóstica. Ejemplo: paciente que acude por un dolor torácico.
- Entrevista informativa y/o prescriptiva: Modalidad de entrevista en la que el profesional debe informar y/o prescribir unos consejos. Puede ser la segunda parte de una entrevista semiológica. Ejemplo: debemos recomendar la mejor estrategia para un paciente con una fuerte bronquitis.
- Entrevista motivacional: Modalidad de entrevista en la que el profesional trata de cambiar hábitos y actitudes a partir de la propia motivación que el paciente es capaz de generar. Ejemplo: Paciente fumador que desea dejar de fumar.
- Entrevista operativa: Modalidad de entrevista en la que profesional y paciente tienen claro el contenido de la entrevista: control de un determinado padecimiento, aplicación de una técnica, etc. Ejemplo: paciente que acude para una cura de una herida.

-----O-----

Si un profesional sanitario atiende a personas con enfermedades que puedan suponer un peligro para la salud pública:

1. Podrá denunciarlo a la autoridad competente
2. Deberá denunciarlo a la autoridad competente
3. Su obligación de secreto profesional le impide denunciarlo
4. Sólo está obligado denunciarlo si se trata de enfermedad grave

Resp. Correcta: 2

Comentario: Existen excepciones a la obligación del secreto profesional de los profesionales sanitarios: - Situaciones que puedan suponer un peligro para la salud pública o para terceras personas. A esto se le llama Estado de Necesidad en el Código Penal art. 20.5, que consiste en la vulneración de un derecho para evitar un mal mayor. Así, los profesionales sanitarios tienen la obligación de declarar los casos de enfermedades infecto-contagiosas detalladas por la Autoridad Sanitaria, con fines epidemiológicos y de prevención.

-----o-----

Paciente de 90 años, pluripatológico, diagnosticado de insuficiencia cardiaca congestiva en fase terminal que ha precisado múltiples ingresos hospitalarios. Durante el ingreso actual se constata una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 15%, recibiendo tratamiento con oxigenoterapia, vasodilatadores, diuréticos, betabloqueantes y dobutamina, a pesar del cual está en anasarca con fallo multiorgánico y se encuentra con disnea grado IV. La actitud MÁS adecuada en el momento actual, sería:

1. Cateterismo cardiaco con angiografía coronaria e implantación de stent.
2. Envío a su domicilio para que fallezca allí acompañado de su familia.
3. Administración de morfina intravenosa, junto con escopolamina y midazolam.
4. Aumentar el tratamiento diurético combinando furosemida y eplerenona hasta normalizar el balance hídrico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Nos encontramos ante un paciente en fase terminal de su enfermedad con ausencia de respuesta al tratamiento óptimo, con lo que en este momento debe primar el confort del paciente sobre las medidas terapéuticas, por lo que es necesario administrar tratamiento sintomático. La morfina ayuda a controlar la disnea, la escopolamina es un anticolinérgico que ayuda a controlar las secreciones y los estertores, y el midazolam es una benzodiazepina de acción rápida que puede ayudar a sedar al paciente en caso necesario.

-----o-----

Una paciente de 79 años con cirrosis hepática, cáncer de colon desestimado para cirugía y con insuficiencia cardiaca en estadio 4 de la NYHA, ingresa por aumento de su disnea y anasarca, con intensa disnea e insuficiencia respiratoria crónica. Durante el ingreso la paciente presenta además fallo renal agudo (sobre una ERC E-4). Existe refractariedad al tratamiento con furosemida. Señales cuál de las siguientes actitudes le parece más adecuada:

1. Administrar morfina hasta que ceda la disnea y comenzar diálisis urgente.
2. Comunicar a la familia que la paciente va a morir y no se puede hacer nada por ella.
3. Informar a la familia del mal pronóstico de la situación e indicar tratamiento sintomático paliativo.
4. Aumentar la dosis de furosemida e iniciar tratamiento con eplerenona.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En este caso se debe dar prioridad al tto. sintomático.

-----o-----

Respecto a los conflictos éticos sobre la terminalidad, es CIERTO que:

1. Difieren sustancialmente respecto a los que se pueden plantear en pacientes ingresados en UCI.
2. En los pacientes en situación terminal la hidratación o la alimentación no se deben considerar medidas “susceptibles de limitación”.
3. Es frecuente que se pueda caer en la obstinación terapéutica o diagnóstica en pacientes en situación terminal.
4. Los problemas de comunicación/información son poco frecuentes en la práctica clínica habitual.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Especialmente en el caso de pacientes con insuficiencia terminal de órgano sólido, no es infrecuente la “obstinación” en la resolución de las exacerbaciones agudas de la patología de base, incluso a pesar de que el paciente pueda encontrarse en situación de terminalidad (respuesta 3 correcta).

-----o-----

Paciente de 62 años con diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón con metástasis ganglionares, hepáticas y óseas, encamado todo el día, en tratamiento sintomático con morfina y dexametasona, que comienza con agitación psicomotriz progresiva que no responde a la administración de dos ampollas de haloperidol. Se le realiza analítica que evidencian natremia de 95 mEq/L. Señale cuál de las siguientes actitudes terapéuticas le parece MÁS adecuada:

1. Continuar con la administración de 5 mg de haloperidol cada 4 horas hasta alcanzar 30 mg.
2. Sedación con midazolam en dosis ascendente hasta control sintomático por agitación como evento terminal.
3. Administración de sueroterapia hipertónica, monitorización de diuresis y administrar tolvaptán si la respuesta no es idónea.
4. Restricción de líquidos y control de diuresis, con monitorización de constante y realizar una nueva analítica a las 4 horas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico sobre un paciente que se encuentra en fase terminal de su enfermedad, por lo que, ante un cuadro confusional probablemente refractario al tratamiento específico, se debe iniciar sedación paliativa con midazolam por vía subcutánea o intravenosa (respuesta 2 correcta).

-----o-----

El uso de sonda nasogástrica en enfermos terminales debe quedar restringido a situaciones muy concretas. Una de las siguientes afirmaciones NO es correcta. Señálela:

1. Problemas obstructivos altos que originan disfagia u odinofagia intensas.
2. Anorexia secundaria al síndrome sistémico derivado de la progresión tumoral.
3. Disfunciones epiglóticas.
4. Fístula orofaríngea.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Cuando la debilidad y la anorexia son debidas al síndrome sistémico de progresión de enfermedad, la sonda no resolverá ninguno de estos problemas.

-----O-----

Si la renuncia a realizar una transfusión necesaria, es realizada por el representante de un menor:

1. No se respetará la decisión del representante del menor
2. Se respetará la decisión del representante del menor
3. Se debe recabar el consentimiento de la autoridad judicial
4. Se tomará la decisión por el médico responsable

Resp. Correcta: 3

Comentario: La negativa a recibir transfusiones sanguíneas por parte de miembros de determinados grupos religiosos por considerarlas contrarias a sus creencias: Si el paciente el mayor de 16 años, con plena capacidad, se debe respetar su decisión. Si el paciente es un menor de edad o incapaz, y la renuncia a la transfusión es realizada por su representante, se debe de recabar el consentimiento de la autoridad judicial, en el que primará el pº de curar sobre el de la libertad religiosa

-----O-----

Todos los siguientes tipos de dolor son refractarios al tratamiento con fármacos opiáceos, EXCEPTO el dolor:

1. Óseo.
2. Por tenesmo rectal.
3. Por distensión gástrica.
4. Por espasmo muscular.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los dolores sensibles a opioides son: visceral, primario con exceso de nocicepción, óseo, y dolor por compresión nerviosa. Las demás opciones de respuesta son insensibles a los opioides.

-----O-----

Nos encontramos ante un paciente en situación terminal en fase de agonía. ¿Cuál sería la actitud MÁS adecuada respecto a su alimentación?

1. Alimentación parenteral con dieta hiperproteica a través de una vía central.
2. Pequeñas ingestas de zumo e higiene buco-oral con enjuagues antisépticos.
3. Colocación de sonda nasogástrica y alimentación enteral hiperproteica.
4. Sueroterapia con aporte gluco-electrolítico estándar y controles estrictos de la homeostasis.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En situación de agonía la dieta debe limitarse a pequeñas cantidades de líquidos y cuidados de la boca (respuesta 2 correcta). La hidratación o la nutrición parenteral no mejoran el estado de los enfermos agónicos, y la mayor parte de la medicación puede administrarse por vía subcutánea o rectal.

-----O-----

Un paciente de 79 años de edad que vive con su hija y su yerno es traído a urgencias por alteración progresiva del nivel de conciencia. Su hija refiere que ha pasado los últimos 3 días en la cama con ideas delirantes. La exploración física evidencian úlceras en sacro avanzadas con eritema adyacente y equimosis en brazos y piernas. Señale cuál es el primer diagnóstico a tener en cuenta:

1. Sepsis de origen cutáneo.
2. Intoxicación farmacológica.
3. Abuso del anciano.
4. Demencia no diagnosticada.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los síntomas indican un cuidado y manejo inadecuados del paciente en el domicilio.

-----O-----

Con respecto a la actitud del médico en los casos de rechazo, señale la afirmación CORRECTA:

1. El médico tiene la obligación ética de intentar persuadir, convenciendo con razones al paciente, para que reconsidere su postura.
2. El médico, una vez respetada su decisión de rechazo, dará de alta al paciente sin obligación explorar tratamiento alternativos.
3. No es labor del médico, sino de las autoridades judiciales, investigar la posible existencia de coacciones externas por parte de la familia que determinen su decisión de rechazo.
4. El médico deberá aceptar sin más la decisión del paciente.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El médico tiene la obligación ética de defender su decisión clínica ante la situación de rechazo (respuesta 1 correcta); para ello, el médico tratará de influir en el paciente, ganando su confianza y convenciendo con razones. A esto se denomina persuasión. Si con las razones que justifican su postura, el médico no consiguiese convencer al paciente, respetará su posición y propondrá la adopción de medidas alternativas.

-----O-----

¿Qué dice la deontología respecto a la limitación de los esfuerzos terapéuticos y la sedación terminal?

1. Si el estado clínico del paciente no le permite tomar decisiones, el médico consultará con la familia qué hacer, aunque el paciente haya dejado indicaciones explícitas sobre ello.
2. Cuando no sea posible la mejoría o la curación permanece la obligación de aplicar medidas para conseguir el bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida.
3. El médico deberá emprender acciones terapéuticas aunque no haya esperanza de beneficios para el

enfermo, porque la obligación del médico es curar.

4. Si el paciente manifiesta voluntad explícita de rechazar un tratamiento para prolongar su vida, el médico no tendrá en cuenta dicha voluntad.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Siempre que exista un estudio pormenorizado del caso, si hay una indicación para realizar limitación de los esfuerzos terapéuticos o sedación terminal, la deontología apoya dichas medidas. Mucho más si se cuenta con la autorización del paciente, algo que no siempre es posible por la mala situación clínica de muchos pacientes terminales, que pierden la capacidad de decidir.

-----O-----

Todas las siguientes afirmaciones en relación al tratamiento del dolor oncológico son adecuadas, EXCEPTO:

1. El manejo de los analgésicos se basa en una administración regular pautada y dosis de rescate a demanda.
2. Habitualmente se utilizan fármacos coadyuvantes (antidepresivos, esteroides, ansiolíticos, antiepilépticos, etc.) para optimizar el control del dolor.
3. Ocasionalmente se utiliza un placebo para poder determinar el predominio del componente psicológico en la etiología del dolor.
4. La vía de elección es la oral y en la mayoría de los pacientes puede ser utilizada hasta la fase terminal de la enfermedad.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Nunca se utiliza placebo en el tratamiento del dolor en pacientes paliativos.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a la fase final de la enfermedad?

1. Paciente con cáncer de próstata con metástasis óseas en tratamiento con acetato de abiraterona.
2. Paciente con cáncer de mama con metástasis hepáticas que únicamente ha recibido tratamiento con letrozol.
3. Paciente con cáncer de pulmón tratado con radioterapia hace 15 meses, con recaída local y metástasis ganglionares y hepáticas, sin respuesta a tercera línea de tratamiento con quimioterapia.
4. Paciente con glioblastoma multiforme intervenido hace una semana, pendiente de iniciar tratamiento adyuvante con radioterapia y quimioterapia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La opción de respuesta 3 es la única que cumple con las características de enfermedad terminal: enfermedad avanzada, falta de respuesta a tratamiento específico, sintomatología intensa y múltiple, gran impacto emocional en el paciente y su familia relacionado con la presencia de la muerte, y pronóstico de vida inferior a seis meses (respuesta 3 correcta).

-----O-----

En la información al paciente con cáncer hay que tener en cuenta:

1. Rigor científico y terminológico.
2. En caso de tumores de diagnóstico en situación avanzada, no es conveniente decir la verdad acerca del diagnóstico o pronóstico que se estima para el paciente.
3. El objetivo de que el médico dé información es evitar que los pacientes le denuncien.
4. Evitar la palabra “cáncer”.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Hablar del cáncer con rigor, usar de manera correcta los términos científicos sin ofrecer datos incorrectos o interpretaciones erróneas sobre un tipo de patología, así como sobre sus posibilidades de tratamiento (quimioterápico, radioterápico, quirúrgico, etc.), facilita el establecimiento de una correcta relación clínica y establecer un plan de tratamiento acorde a la voluntad del paciente.

-----O-----

Un paciente de 17 años afecto de un déficit de factor VIII de la coagulación, sufre un accidente con su bicicleta. A su llegada al hospital se encuentra consciente y orientado, pero presenta unos niveles de hemoglobina de 4,3 g/dl. El médico de guardia que valora la analítica indica que la paciente debe recibir una transfusión sanguínea de forma urgente, pero las convicciones religiosas del paciente y de su familia le impiden aceptar dicho tratamiento, con lo que ejerce un vehemente rechazo al mismo. El médico debe:

1. Contactar con el juez de guardia para ponerle en conocimiento de la situación y esperar a que ordene la realización del tratamiento.
2. Abstenerse de realizar la transfusión e iniciar una sedación paliativa para que el paciente no sufra.
3. Proceder a realizar la transfusión a pesar de la negativa del paciente y de sus padres, y además ponerlo en conocimiento del juez.
4. Solicitar valoración de la competencia del paciente por parte del psiquiatra de guardia.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El paciente se encuentra en situación de riesgo vital.

-----O-----

Pepe es traumatólogo en el hospital en el que usted trabaja. Es un magnífico médico y docente, con gran trayectoria en sus 35 años de profesión. La relación con sus pacientes y compañeros de trabajo es excelente. Antonio, otro compañero del hospital, le comenta que últimamente Pepe se muestra más despistado de lo habitual, aunque él no le da mucha importancia, y continúa con su trabajo asistencial sin ningún problema. Sin embargo, los despistes son cada vez más frecuentes, hasta el punto de que Antonio y usted han detectado algunos errores en sus técnicas, hasta entonces muy perfeccionadas, aunque por suerte sin repercusión importante para los pacientes. No obstante, Pepe continúa su trabajo y no parece darse cuenta de sus pequeños fallos. ¿Cómo actuarían Antonio y usted?

1. Hablando con la Gerencia del hospital, para que conozcan el caso de Pepe y decida cómo actuar.
2. Hablando con el jefe de servicio de traumatología, para que conozca el caso de Pepe y decida cómo actuar.
3. Hablando con Pepe y explicándole la situación, y acudiendo al Colegio de Médicos si se negara a

razonar.

4. Hablando con otros compañeros del hospital, para que conozcan el caso de Pepe y así tomar una decisión entre todos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Si un médico advierte un deterioro en las habilidades de un compañero (siendo este inconsciente de tales fallos), está obligado a comunicárselo a dicho compañero e incluso, si es necesario, deberá comunicarlo al Colegio de Médicos con la correspondiente discreción. Esto no supone una falta al deber de confraternidad, ya que la prioridad es el beneficio del paciente.

Se establece así en el “Apartado 3 del Artículo 22 del Código de Deontología Médica”, exponiendo: “Si el médico no fuera consciente de tales deficiencias y estas fueran advertidas por otro compañero, este está obligado a comunicárselo y, en caso necesario, lo pondrá en conocimiento del Colegio de Médicos, de forma objetiva y con la debida discreción. Esta actuación no supone faltar al deber de confraternidad, porque el bien de los pacientes es siempre prioritario”.

-----O-----

Los recursos específicos de los cuidados paliativos son imprescindibles debido al incremento de las necesidades y de la complejidad de las demandas. Todas las siguientes son características fundamentales de los cuidados paliativos, EXCEPTO:

1. Realizar atención integral y puntual de enfermos y familia.
2. Utilizar regularmente protocolos y documentación específicos.
3. Iniciar tratamiento sintomático lo antes posible y realizar un seguimiento estrecho de la respuesta al mismo.
4. Elegir los tratamientos con una posología fácil de cumplir y adecuar la vía de administración a la situación del paciente, manteniendo la vía oral siempre que sea posible.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La atención debe ser integral y continuada a pacientes y familiares. Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

El consentimiento informado es un formulario ad hoc que pretende respetar el principio de autonomía del paciente. Una de las siguientes afirmaciones es FALSA, señálela:

1. Se realiza fundamentalmente de forma verbal y por escrito.
2. Se requiere la firma explícita del paciente cuando este va a ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos que pueden generar secuelas graves o riesgo vital.
3. En casos de emergencia vital será imprescindible que la familia del paciente proceda a la firma del consentimiento si este no se encuentra capacitado.
4. El consentimiento informado siempre debe constar en la Historia Clínica del paciente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En casos de emergencia vital se procederá a realizar todos los procedimientos necesarios para preservar la vida del paciente sin que sea necesario obtener el consentimiento informado explícito por parte del paciente o de su familia (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

En la situación de enfermedad terminal concurren una serie de características que son importantes no solo para definirla, sino también para establecer adecuadamente la terapéutica. Todas las siguientes son características fundamentales de la enfermedad terminal, EXCEPTO:

1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.
2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.
3. Presencia de sintomatología intensa multifactorial y variable.
4. Pronóstico de vida inferior a nueve meses.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se considera enfermedad terminal aquella con un pronóstico vital inferior a seis meses. El resto de las opciones son correctas.

-----O-----

Podemos definir la agonía como el estado que precede a la muerte en aquellas situaciones en las que la vida se extingue gradualmente. Con respecto a los cuidados en las últimas horas de la vida, es FALSO que:

1. No parece que la sueroterapia o la nutrición parenteral aporten beneficio en esta última fase.
2. En caso de padecer agitación, se suele preferir el empleo de sedantes tipo benzodiacepinas de acción ultracorta como el midazolam por su efecto sedante, miorrelajante y ansiolítico.
3. El paciente, al perder el reflejo nauseoso y mostrar disfagia, también presenta acumulación de secreciones orales, lo que produce unos ruidos característicos llamados estertores, que podemos disminuir mediante el uso de fármacos como la pilocarpina.
4. La limpieza en el interior de la boca, la aplicación de lubricantes en los labios y el uso de lágrimas artificiales son medidas que sustituyen los intentos de alimentación en esta fase.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Para disminuir los estertores debemos utilizar fármacos anticolinérgicos como la escopolamina o la buscapina. La pilocarpina es un fármaco agonista no selectivo de los receptores muscarínicos del sistema nervioso parasimpático que actúa a nivel del receptor muscarínico M3, en especial debido a su aplicación tópica, como en casos de glaucoma y xerostomía (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

Antonio, Residente de primer año de Medicina se encuentra realizando una guardia de Urgencias. Está un poco nervioso porque aún no se acostumbra a llevar el ritmo de la

guardia, y porque la tarde y parte de la noche ha sido ajetreada. A las 2 AM, Paco, su adjunto, le dice a Antonio que tiene un asunto que atender, pero que no tardará mucho, y que deja a su cargo a los pacientes que vengan. A la media hora Paco no ha vuelto, los pacientes se acumulan y Antonio tiene varias altas pendientes. ¿Qué haría usted a continuación si fuese Antonio?

1. Firmaría las altas de los pacientes para despejar el sistema, disminuir la espera y no colapsar las Urgencias.
2. Correría a pedir ayuda a un Residente mayor.
3. Pediría consejo a mi co-Residente.
4. Buscaría a Paco para que revise los informes y firme las altas de los pacientes.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los Residentes no pueden firmar altas sin la supervisión de un adjunto que firme con ellos. La ley establece que la formación del Residente debe realizarse de forma progresiva y tutelada. Así se recoge en el Apartado 3.d del Artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, de la siguiente manera: “Los Residentes deberán desarrollar, de forma programada y tutelada, las actividades previstas en el programa, asumiendo de forma progresiva, según avancen en su formación, las actividades y responsabilidades propias del ejercicio autónomo de la especialidad” (respuesta 4 correcta).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece MENOS apropiada para atender de forma óptima las necesidades de los enfermos terminales?

1. Fomentar la comunicación entre el enfermo, su familia y los profesionales sanitarios.
2. Fijar un día concreto a la semana para acudir al especialista correspondiente y revisar el tratamiento pautado.
3. Formar un equipo interdisciplinario para optimizar el tratamiento del paciente.
4. Atender las necesidades del entorno familiar del paciente en relación con la enfermedad.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

No debemos establecer fechas concretas en el tratamiento de los enfermos terminales, puesto que tanto el tratamiento como el seguimiento, debe realizarse a demanda, primando en todo momento la confortabilidad y la calidad de vida del paciente.

-----O-----

Con respecto a la utilización de AINEs en el tratamiento del dolor en cuidados paliativos, una de las siguientes afirmaciones NO es correcta. Señálela:

1. Son especialmente útiles en procesos dolorosos secundarios a tumores con aumento de producción de prostaglandinas (mama, próstata y tiroides).
2. Se pueden usar como antipiréticos en procesos febriles de etiología tumoral.
3. Tienen efecto antiagregante plaquetario.
4. No tienen techo analgésico; al aumentar la dosis aumentamos el efecto analgésico sin aumentar la tasa de efectos secundarios a partir de un umbral determinado.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los AINEs tienen techo analgésico, si aumentamos la dosis no aumentamos la analgesia a partir de un umbral, pero sí los efectos secundarios (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----o-----

En el ámbito de los cuidados paliativos es frecuente el uso de fármacos opioides. Señale cuál es el efecto secundario MÁS frecuente de estos fármacos y su posible tratamiento:

1. Euforia: Haloperidol.
2. Depresión respiratoria: Oxigenoterapia.
3. Tos: Dextrometorfano.
4. Estreñimiento: Naloxona.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El estreñimiento es el efecto secundario más frecuente y no disminuye durante el curso del tratamiento. Suele responder al uso de laxantes, pero en los casos refractarios se puede utilizar naloxona por vía oral 0,4-0,8 mg, ya que actúa selectivamente sobre los receptores intestinales.

-----o-----

Con respecto a la objeción de conciencia en el supuesto de la solicitud de aborto por parte de una paciente que solicite tal intervención, señale lo incorrecto:

1. Los objetores están obligados a suministrar información para la toma de decisiones.
2. Pueden ser objetores todos los profesionales implicados en el proceso.
3. Es un derecho no fundamental que es personal y que debe ser manifestado previamente y por escrito.
4. Es un derecho que se halla sometido al derecho a una atención sanitaria óptima.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Sólo pueden ser objetores de conciencia aquellos profesionales implicados de manera directa en la realización del aborto. Esta decisión ha de ser personal, no puede ser sobrevenida (es decir hay que manifestarla previamente y por escrito para que quede registrada en el expediente del profesional)

-----o-----

La creación de los Comités de Ética como principio de la Bioética, se contempla en:

1. El Código de Nüremberg.
2. El Convenio de Oviedo.
3. Los principios de Tavistock.
4. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS:

"a) Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:

a) evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales suscitados por los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;

b) prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos;

c) evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y contribuir a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el ámbito de la presente Declaración;

d) fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la bioética, así como su participación al respecto".

-----O-----

Pablo es un neonato con un síndrome malformativo cuya esperanza de vida es muy limitada y que lleva desde el nacimiento ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica, entre otras medidas de soporte vital, sin experimentar ninguna mejoría. Tras ser minuciosamente valorada su situación clínica y su pronóstico de vida con sus padres y un Comité de Ética, se determina que las medidas que se están aplicadas son “desproporcionadas” y se decide limitar el esfuerzo terapéutico. Respecto a esta medida, es cierto que:

1. Si se decide limitar el esfuerzo terapéutico, debe retirarse cualquier tipo de soporte médico, tanto fútil como no fútil, para evitar prolongar el sufrimiento del mismo.
2. A pesar de limitar el esfuerzo terapéutico, deben siempre llevarse a cabo medidas positivas que proporcionen al paciente una muerte digna.
3. El concepto de limitación del esfuerzo terapéutico incluye no iniciar una medida nueva (como la reanimación cardiovascular), sin embargo, no incluye retirar una medida previamente instaurada (como la ventilación mecánica, en este caso).
4. La limitación del esfuerzo terapéutico es el eufemismo de eutanasia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En UCI de pediatría y neonatología, la LET es especialmente compleja, al tratarse de niños o de recién nacidos. Los tipos de LET más habituales en pediatría y neonatología son la limitación de la ventilación mecánica, de fármacos vasoactivos y la no reanimación cardiopulmonar.

Existen dos posibilidades ante una decisión de LET: no iniciar una medida (withholding) o retirar una medida previamente instaurada (withdrawing). En general, se tiende a ver las dos posibilidades como moralmente equivalentes, aunque psicológicamente resulta más difícil retirar una medida que decidir no instaurarla.

Finalmente, si el paciente es candidato a LET, proceder a realizarla. Para ello, se deben evitar las medidas desproporcionadas, inútiles y fútiles; y, además, se debe decidir qué patologías sí se tratan (p. ej., si se administran antibióticos, transfusiones...), son las medidas “intermedias” (Positivas). No se deben olvidar establecer las medidas/tratamientos paliativos que sean necesarios.

-----O-----

Varón de 76 años con diagnóstico de cáncer gástrico avanzado que recibe tratamiento con morfina oral, manteniendo el dolor controlado. Presenta caquexia avanzada. En las últimas 24 horas comienza con un cuadro de taquicardia, hipotensión, oliguria y signo del pliegue positivo, con lo que su médico de familia decide traslado al hospital. Ante esta situación, señale su impresión diagnóstica y el tratamiento PRIORITARIO:

1. Respuesta simpática al dolor: betabloqueantes y opioides mayores administrados por vía subcutánea.
2. Deshidratación por ingesta insuficiente: reposición de líquidos, potasio y heparina de bajo peso molecular.
3. Hiponatremia por SIADH: restricción hídrica y suero salino hipertónico.
4. Alteración hemodinámica por secuestro de líquidos en tercer espacio: suero, corticoides, diuréticos y paracentesis evacuadora.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La deshidratación es un proceso frecuente en pacientes oncológicos terminales, sobre todo en los que sufren tumores gastrointestinales. Se manifiesta por sequedad de mucosas, astenia, obnubilación, agitación, cefalea, signo del pliegue, disminución de volemia, taquicardia, hipotensión, oliguria y azoemia. El tratamiento se basa en reposición de líquidos, potasio y heparina de bajo peso molecular para prevenir fenómenos tromboticos (respuesta 2 correcta). En función de la evolución y de los que se hable con el paciente, se valorará si es preciso optimizar el tratamiento sintomático.

-----o-----

Con respecto a la existencia de equipos de cuidados paliativos hospitalarios y a domicilio, señale la afirmación FALSA:

1. Existen estudios que demuestran una menor mortalidad de los pacientes en programa de cuidados paliativos respecto a los que continúan con tratamiento médico (quimioterápico) activo en fases avanzadas de su enfermedad oncológica.
2. Permite la inversión de la tendencia del lugar de fallecimiento, facilitando que un alto porcentaje de estos ocurra en el domicilio de los pacientes.
3. Ayuda a facilitar la identificación y comprensión por parte del paciente y de sus cuidadores principales del diagnóstico y pronóstico, y así permiten una mejor planificación de los cuidados.
4. Permite suplir la labor del médico de Atención Primaria en un grupo de pacientes de atención compleja.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La colaboración entre el equipo de Cuidados Paliativos y los equipos de Atención Primaria es esencial, siendo esta uno de los factores que determina de manera más clara las posibilidades del paciente de fallecer en domicilio (opción 4 falsa, por lo que la marcamos).

-----o-----

Una paciente de 54 años es diagnosticada de carcinoma de colon con carcinomatosis peritoneal. Presenta un cuadro de vómitos, estreñimiento y dolor intestinal tipo cólico de 48 horas de evolución, que en las últimas tres horas se acompaña de hipotensión,

hipoventilación y obnubilación que finalmente desemboca en el fallecimiento de la paciente. De las siguientes posibles causas, indique cuál le parece la MÁS probable como causa del cuadro clínico de la paciente:

1. Íleo paralítico farmacológico.
2. Fallo hepático fulminante por metástasis hepáticas.
3. Anorexia por ascitis abdominal a tensión.
4. Oclusión intestinal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La oclusión intestinal es un cuadro muy frecuente en el cáncer de colon y ovario. Se manifiesta con dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas y vómitos, ausencia de peristaltismo (si es de causa mecánica), o disminución (si es de causa funcional). Localmente se produce estasis circulatorio, liberación de sustancias hipotensoras, acumulación de líquido en asas, y finalmente shock y aumento de la presión abdominal con hipotensión.

-----O-----

Respecto a la sedación terminal, señale la opción INCORRECTA:

1. Está indicada en pacientes que se encuentran cerca de su fallecimiento.
2. Debe emplearse para aliviar síntomas refractarios a los tratamientos convencionales.
3. No está indicada cuando lo solicita el paciente en situación terminal aduciendo motivos existenciales.
4. Debe emplearse aunque se sospeche que va a ser la responsable de acortar la vida del paciente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El objetivo del tratamiento paliativo no es otro que el de aliviar los síntomas del paciente, asegurando su confort, siendo prioritario en pacientes en situación terminal. Por ello, se debe administrar en este tipo de pacientes tanto si presenta síntomas físicos como si lo solicita por motivos existenciales (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

El tratamiento del dolor en enfermos terminales es complejo y requiere conocer en profundidad todas sus características. Todas las siguientes opciones son válidas en el tratamiento del dolor en enfermos terminales, EXCEPTO:

1. Los analgésicos deben suministrarse a demanda del paciente, nunca con horarios establecidos.
2. Jamás se debe usar un placebo.
3. Siempre que sea posible se debe utilizar la vía oral, incluso al final de la vida.
4. No utilizar habitualmente preparados analgésicos compuestos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En enfermos terminales los analgésicos deben suministrarse a horas fijas, con dosis extra de rescate en caso de que sea necesario. Es importante identificar muy bien el tipo de dolor en estos pacientes, y prescribir el

analgésico apropiado específico; los preparados compuestos no son apropiados. El uso de placebo es clínica y éticamente inaceptable. La vía oral es de elección.

En el control de síntomas de los pacientes paliativos, una de las siguientes actuaciones NO es adecuada. Señálela:

1. Realizar una evaluación etiológica que nos permita determinar si un síntoma es atribuible a la enfermedad neoplásica, secundario a los tratamientos recibidos o sin relación con ninguno de ellos.
2. Iniciar un tratamiento lo antes posible y determinar la respuesta al mismo.
3. Tratar siempre los síntomas que pueda presentar el paciente con todos los medios disponibles.
4. Monitorizar los síntomas mediante el uso de instrumentos de medida estandarizados.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es muy importante valorar la relación riesgo/beneficio y ser conscientes de que no siempre es necesario tratar todos los síntomas, como administrar antibióticos a un paciente en fase agónica con fiebre de etiología infecciosa.

Señale cuál de las siguientes situaciones se corresponde con la fase terminal de la enfermedad:

1. Paciente de 45 años con hepatocarcinoma locorregionalmente avanzado que no es candidato a trasplante y ha progresado a dos tratamientos con quimioterapia intraarterial y etanol.
2. Paciente de 75 años con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama con metástasis en columna dorsal que está en tratamiento con hormonoterapia.
3. Paciente de 67 años con diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón en tratamiento de primera línea con quimioterapia.
4. Paciente de 58 años con glioblastoma multiforme intervenido hace un año con recidiva local, pendiente de iniciar tratamiento con Temozolamida.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El paciente expuesto en la opción de respuesta 1 tiene una esperanza de vida menor de seis meses y ha fracasado a los mejores tratamientos disponibles para su enfermedad, con lo que cumple los requisitos necesarios para decir que se encuentra en situación terminal (respuesta 1 correcta). Los pacientes de las demás opciones de respuesta no cumplen dichos requisitos.

Usted es médico de familia del hospital de Motril. Estando de guardia, llega a Urgencias un paciente con crisis asmática e insuficiencia respiratoria grave que no responde a tratamiento habitual y precisa de ventilación mecánica invasiva. El residente de cuarto año de neumología comienza a realizar la intubación, pero se trata de una intubación difícil y no lo consigue. Los adjuntos de guardia de intensivos, neumología y de anestesiología han sido alertados, pero todavía no han llegado. El

paciente está empeorando, adquiriendo un color azulado. Usted conoce las distintas técnicas de intubación complicada, debido a un curso que realizó el mes pasado. El residente y el enfermero le solicitan ayuda, ¿qué haría en este caso?

1. Esperar a que lleguen los adjuntos y se encarguen del caso, ya que no es de su competencia.
2. Intentar realizar la intubación, puesto que posee los conocimientos para ello.
3. Pedirle al residente que lo intente de nuevo.
4. Llamar a otro residente con más experiencia en intubaciones difíciles.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las técnicas específicas deben realizarse por los facultativos con el título correspondiente a dichas áreas, sin embargo, cualquier titulado en medicina puede realizarlas para el beneficio del paciente si precisa de los conocimientos adecuados. Se recoge en el Artículo 24 del Código de Deontología Médica de la siguiente forma: "los actos médicos especializados deben quedar reservados a los facultativos que posean el título correspondiente, sin perjuicio de que cualquier titulado en medicina pueda, ocasionalmente, realizarlos. A ningún médico, si posee la destreza y los conocimientos necesarios adecuados al nivel de uso que precise, se le puede impedir que los aplique en beneficio de sus pacientes. En ningún caso se podrá atribuir la condición de médico especialista en esa técnica o materia" (respuesta 2 correcta).

-----o-----

Los elementos fundamentales que definen la enfermedad terminal son todos los siguientes excepto uno, señálelo:

1. Pronóstico de vida muchas veces inferior a seis meses.
2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.
3. Ausencia de otros problemas o sintomatología multifactorial justificante.
4. Gran impacto emocional en el paciente y su familia, así como en el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Suelen existir otros problemas y sintomatología multifactorial.

-----o-----

Un joven de 23 años, presenta de forma brusca un dolor punzante en el hemitórax izquierdo que se acompaña de disnea progresiva. Decide acudir al Servicio de Urgencias del Hospital más próximo. El médico que lo atiende constata obnubilación, cianosis, taquipnea y una exploración física compatible con neumotórax que se confirma en la radiografía de tórax. La saturación de oxígeno es del 70%. El médico cree que debe colocarse un drenaje torácico. ¿Cuál es la actitud CORRECTA?

1. Solicitar el consentimiento informado antes de practicarlo.
2. Practicar directamente el drenaje ya que en las situaciones de urgencia puede prescindirse del consentimiento informado.
3. Intentar localizar a un familiar para que decida por el paciente.
4. No debe solicitarse dado que el drenaje no es necesario.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La respuesta correcta es la 2, ya que los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento: &&&a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias. &&&b) Cuando hay riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización.

-----O-----

Indique cuál de las siguientes NO ES una condición necesaria para aceptar una decisión de rechazo por parte del paciente:

1. Ausencia de coacciones externas
2. Capacidad de entender la información recibida.
3. Capacidad de procesar y reflexionar sobre su situación, valorando las consecuencias de su decisión.
4. Tener más de 18 años

Resp. Correcta: 4

Comentario: En el momento actual, la mayoría de edad para tomar decisiones sanitarias, siempre que el paciente no esté incapacitado judicialmente o presente alguna alteración en su capacidad, son los 16 años cumplidos.

-----O-----

La bioética se ha definido como el estudio sistemático de las dimensiones, conductas y políticas de las ciencias de la vida y de la salud. Señale cual de los siguientes no está incluido en los 4 principios básicos de la bioética:

1. Autonomía.
2. Benevolencia.
3. No maleficencia.
4. Justicia.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El principio en beneficencia, no benevolencia.

-----O-----

¿Qué principio ético requiere la solicitud de consentimiento informado del paciente para su participación en un ensayo clínico?

1. Autonomía.
2. No maleficencia.
3. Equidad.
4. Justicia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El consentimiento informado se basa en el derecho de autonomía, ya que el paciente tiene derecho a decidir si quiere o no quiere realizarse cierta intervención, o asumir ciertos riesgos y decidir él mismo sobre su salud.

-----O-----

Señale cuál de las siguientes definiciones se corresponde con los objetivos de los cuidados paliativos:

1. Lograr el confort físico, emocional y espiritual del paciente.
2. Mantener al paciente aislado de la situación mediante la sedación.
3. Mantener al paciente con vida el tiempo que sea necesario.
4. No abandonar y controlar todos los síntomas del enfermo y su familia, acompañando en el proceso de duelo.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La opción 4 corresponde a los objetivos de los cuidados paliativos, entre los cuales también se menciona aliviar el dolor y otros síntomas, y mejorar la calidad de vida.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los principios básicos de la Bioética?

1. "Son las fuentes fundamentales a partir de las cuales justificamos las pautas para la acción, los deberes y las reglas. "
2. La capacidad de comprensión y la falta de coerción externa no son aplicables a la hora del ejercicio de la autonomía.
3. El principio de beneficencia y el de autonomía no están relacionados y, por tanto, no deben entrar en conflicto.
4. El principio de justicia se refiere a la compensación debida a los pacientes por las posibles malas prácticas médicas.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La respuesta 1 es correcta. La capacidad de comprensión y la falta de coerción externa son fundamentales a la hora del ejercicio de la autonomía.

El principio de beneficencia y el de autonomía están relacionados y en ocasiones pueden entrar en conflicto.

El principio de justicia está en relación con la distribución equitativa de los recursos.

-----O-----

¿De qué información tiene obligación de guardar secreto el profesional sanitario?

1. De aquella que pueda vulnerar el honor o intimidad del paciente.
2. De la relativa a la enfermedad que el paciente padece.
3. De la relativa a las intervenciones que se le realicen al paciente.
4. De toda información que llegue a conocer de un paciente.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Forma parte del código deontológico la obligación de guardar secreto por el profesional sanitario de toda la información que llegue a conocer de un paciente.

-----o-----

Una de las siguientes NO es una característica de la sedación paliativa:

1. No debe acelerar la muerte
2. La finalidad es disminuir el nivel de consciencia para evitar sufrimiento
3. Puede incluir un tratamiento intensivo del dolor
4. Un tipo de sedación paliativa es la sedación en la agonía

Resp. Correcta: 1

Comentario:

(Aunque no se pretenda causar directamente la muerte, es aceptable ético y legalmente que las acciones llevadas a cabo para evitar sufrimiento puedan acortarla.)

-----o-----

La exigencia que obliga a que las determinaciones diagnósticas y terapéuticas que se tomen con los pacientes respeten escrupulosamente el balance riesgo-beneficio y estén avaladas por la evidencia clínica, responde al principio bioético de:

1. Autonomía.
2. No maleficencia.
3. Beneficencia.
4. Justicia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El enunciado corresponde a la definición del principio bioético de no maleficencia. Con la acción descrita en el enunciado se busca evitar daños innecesarios y que las medidas que se tomen globalmente produzcan mayor beneficio que daño.

-----o-----

En el transcurso de la evolución de la enfermedad terminal pueden aparecer crisis de claudicación familiar. Señale la respuesta FALSA en relación a la respuesta terapéutica:

1. Dar sugerencias sobre cómo comunicarse y relacionarse con el enfermo.
2. Revisar los últimos acontecimientos, esclarecer dudas sobre la evolución y el tratamiento.
3. Dejar a un lado los objetivos terapéuticos establecidos al inicio de la enfermedad terminal.
4. Instaurar medidas de control sintomático.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Es imprescindible volver a recordar a la familia los objetivos terapéuticos establecidos con el enfermo. El resto de opciones son correctas.

La bioética se ha definido como el estudio sistemático de las dimensiones, conductas y políticas de las ciencias de la vida y de la salud. Señale cuál de los siguientes NO está incluido en los cuatro principios básicos de la bioética:

1. Autonomía.
2. Benevolencia.
3. No maleficencia.
4. Justicia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los cuatro principios básicos de la bioética son: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Mujer de 41 años que acude a la consulta de su médico de familia debido a un catarro de vías altas. En la exploración el médico aprecia hematoma periorbitario derecho y equimosis en los brazos, tronco y abdomen. La paciente se pone a llorar y explica que hace unos días sufrió una caída desde un metro de altura cuando estaba buscando algo de la parte alta de un armario. El médico debería:

1. Ponerse en contacto con la asistente social para que le acompañe a la comisaría más cercana a poner una denuncia por malos tratos.
2. Solicitar asistencia al psiquiatra para que ayude a obtener el testimonio de la paciente.
3. Tramitar el parte de lesiones por vía judicial.
4. Prescribir la medicación necesaria para su proceso actual y citar para una nueva revisión al cabo de una semana.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Sin un testimonio de haber sufrido malos tratos no se puede tramitar un parte de lesiones por vía judicial. En este caso el médico deberá prescribir la medicación necesaria para su proceso actual y citar para una nueva revisión al cabo de una semana (respuesta 4 correcta).

Son excepciones al consentimiento informado por parte del paciente todas las siguientes situaciones, excepto una, señálela:

1. Imperativo legal por riesgo para la salud pública.
2. Paciente incapacitado legalmente.
3. Situaciones de máxima urgencia.
4. Convicciones religiosas del paciente.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Se pregunta cuándo el paciente no tiene que realizar el CI

Un obstáculo ético que encuentran los clínicos frecuentemente en UCI es que el paciente intubado no puede expresar verbalmente sus deseos. Esta situación afecta al principio de:

1. Beneficencia.
2. Justicia.
3. Autonomía.
4. Equivalencia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las dificultades de comunicación en el ámbito de los cuidados intensivos han sido desarrolladas extensamente por Levin TT et al, en siguiente trabajo: EndofLife Communication in the Intensive Care Unit. General Hospital Psychiatry 2010;32:433.

Respecto a la toma de decisiones al final de la vida en un paciente en situación de últimos días, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La negativa a intervenciones para conservar la vida del paciente puede considerarse suicidio o incluso asesinato.
2. La administración de antibióticos o la infusión de suero debe evitarse en estas situaciones.
3. Deben suspenderse aquellas actividades que se demuestren no ser útiles para el paciente.
4. Los médicos son los responsables de firmar la orden de no reanimación explicando los motivos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre ética que puede responderse con sentido común. En la etapa final deben realizarse aquellas medidas que garanticen el confort del paciente, evitando aquellas acciones que prolonguen su sufrimiento (opción 1 incorrecta, por lo que la marcamos). Las demás opciones de respuesta son correctas.

El secreto médico consiste en el compromiso que adquiere el médico ante el paciente y la sociedad de guardar secreto de todo lo que hubiera sido confiado por el enfermo o por las exploraciones llevadas a cabo en el transcurso de una actuación médica. En todas las siguientes situaciones es obligatorio revelar el secreto médico, EXCEPTO en la:

1. Denuncia de delitos.
2. Declaración de enfermedades infectocontagiosas.
3. Declaración como testigo o perito.
4. Reclamación de honorarios médicos por vía judicial.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En caso de una reclamación por vía judicial de un cliente que no abona los honorarios, será suficiente con declarar el número de visitas y consultas realizadas, sin señalar nada acerca de la patología que sufría el paciente.

-----O-----

La autopsia médica, se diferencia de la médico-legal en:

1. No la ordena un juez
2. Requiere la autorización de la familia
3. La lleva a cabo un anatomopatólogo
4. Todas las anteriores son correctas

Resp. Correcta: 4

Comentario: a diferencia de la médica, la médico-legal la ordena un juez, es llevada a cabo por 1 o 2 médicos forenses y es independiente de la autorización de la familia.

-----O-----

Las bases de la terapéutica en pacientes terminales son todas las siguientes, EXCEPTO:

1. Atención individual.
2. Promoción de la autonomía y de la dignidad.
3. Concepción terapéutica activa.
4. Importancia del ambiente.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La familia es el núcleo fundamental de apoyo al enfermo, adquiriendo una relevancia fundamental en la atención domiciliaria. La familia requiere medidas específicas de ayuda y educación, por lo que el enfermo y la familia son el objetivo del tratamiento, no solo el enfermo de forma individual (marcamos la opción de respuesta 1).

-----O-----

En el tratamiento del dolor oncológico se utiliza habitualmente la escala analgésica de la OMS para realizar un ajuste óptimo y racional de la analgesia. De las siguientes afirmaciones, señale la FALSA:

1. Si se prescriben simultáneamente dexketoprofeno, dexametasona y gabapentina, se considera que se está utilizando el primer escalón de la escala analgésica de la OMS.
2. No se permite la utilización de fármacos coadyuvantes en el tercer escalón analgésico.
3. El etoricoxib pertenece al primer escalón analgésico.
4. En general, no permite la utilización conjunta de opiáceos débiles (tramadol) y potentes (fentanilo) en dolores de intensidad severa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se permite la utilización de fármacos coadyuvantes en cualquier escalón analgésico. Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

Respecto a las necesidades de un paciente en situación terminal:

1. Se podrían clasificar en control de síntomas, cuidados de comodidad y atención a la calidad del paciente.
2. La calidad de vida se puede estimar de manera precisa según la situación funcional del paciente.
3. El plan de cuidados en un paciente terminal debe ser elegido por los familiares del paciente, pese a que pueda colisionar con la evidencia científica disponible.
4. El control de síntomas es prioritario respecto a los otros dos grupos de cuidados.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La prioridad en los cuidados debe establecerse de acuerdo con las preferencias del paciente, por lo que, en ocasiones, la atención a los síntomas no tiene por qué ocupar un lugar prioritario. La calidad de vida incluye una valoración multidimensional del paciente, por lo que debe ser definida por el propio paciente.

-----O-----

¿Qué es el principio del doble efecto?

1. El efecto secundario de un fármaco.
2. Es el principio que lleva a los médicos a tratar a los pacientes en situación terminal.
3. Es uno de los cuatro principios de la bioética.
4. Es un principio aplicado en la sedación paliativa o en la agonía: pese a que de la aplicación de un/os fármaco/s se siga un acortamiento de la vida como efecto no buscado, no debe haber inconveniente en administrarlo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El principio del doble efecto justifica éticamente la sedación paliativa o en la agonía, de la cual se puede derivar un acortamiento de la vida. Sin embargo, este principio no es ni el único ni el fundamental en que se basa la atención a los pacientes en situación terminal (respuesta 4 correcta).

-----O-----

El manejo de los pacientes al final de la vida es una situación compleja que requiere un protocolo estructurado de decisiones clínicas. Señale cuál de las siguientes opciones NO es correcta:

1. Apoyo psicológico al paciente y sus familiares.
2. Mantener sueroterapia y nutrición parenteral para garantizar la alimentación adecuada.
3. Proporcionar apoyo espiritual en caso necesario.
4. Acompañamiento físico del paciente y de sus familiares.

Resp. Correcta: 2

Comentario: No parece que la sueroterapia o la nutrición parenteral aporten ningún beneficio en esta última fase.

No discriminar a un paciente por motivos sensibles como la raza, la religión, el género o el origen socioeconómico es un ejemplo en la práctica clínica de uno de los principios de la bioética. Selecciónelo:

1. Beneficencia.
2. No maleficencia.
3. Autonomía.
4. Justicia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El principio de la bioética de Justicia es el principio que asegura que, independientemente de los factores relacionados con aspectos personales del paciente, este accede a los medios necesarios en su proceso diagnóstico y terapéutico (respuesta 4 correcta).

Con respecto a la atención a pacientes en situación terminal, es CIERTO que:

1. Las prioridades respecto al plan de cuidados deben establecerse exclusivamente por indicación del equipo médico-enfermero.
2. Los cuidados al final de la vida se dirigen únicamente al confort físico del paciente.
3. La asistencia médica debe ir centrada a la atención física, y la asistencia enfermera, a la atención emocional del paciente.
4. Los cuidados no solo deben dirigirse al paciente, sino también a sus familiares.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los cuidados al final de la vida deben dirigirse a las áreas física, mental, social y emocional del paciente, y deben integrar también a sus allegados (respuesta 4 correcta). Esta atención debe hacerse de manera conjunta, por todo el equipo sanitario, según un plan de cuidados acordado con el paciente conforme a su sistema de valores.

En la evaluación inicial del paciente terminal, todas las actitudes y valoraciones siguientes son adecuadas, EXCEPTO:

1. Valorar necesidades existenciales o espirituales.
2. Interrogar sobre necesidades sociales que incluyan relaciones interpersonales, cuidados y aspectos económicos.
3. Realizar una exploración física rigurosa, a pesar de que sea incómoda.
4. Evaluar síntomas psicológicos.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Al final de la vida se deben evitar todas las medidas desagradables para el paciente, incluso las exploraciones físicas que le pudieran resultar incómodas.

-----O-----

La comunicación de malas noticias es un proceso clínico diario en la práctica habitual. Las malas noticias son aquellas que alteran las expectativas de futuro de la persona. En relación a la comunicación de malas noticias, una de las siguientes afirmaciones NO es correcta. Señálela:

1. Es importante mantener una esperanza real.
2. Se debe averiguar primero qué es lo que sabe el paciente.
3. El bloqueo postinformación ocurre tras pronunciar palabras como cáncer o muerte, la persona no puede recordar nada de lo que se le diga después.
4. Se debe dar toda la información al paciente y a su familia inicialmente para poder resolver sus dudas con rapidez.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En la comunicación de malas noticias es necesario averiguar cuánto quiere saber el paciente y/o su familia antes de ser informados. Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

Señale cuál de los siguientes criterios puede ser utilizado para considerar a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en situación de terminalidad:

1. El desarrollo de hipertensión pulmonar severa y fracaso de ventrículo derecho.
2. Una fracción espiratoria en el primer segundo (FEV1) menor del 45%.
3. La presencia concomitante de una neoplasia de pulmón, cualquiera que sea su estadio.
4. La taquicardia durante el tratamiento con broncodilatadores en el seno de una exacerbación de EPOC.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La aparición de insuficiencia cardiaca de predominio derecho (*cor pulmonale*) es un criterio de enfermedad avanzada en el seno de la EPOC (respuesta 1 correcta). Por otro lado, el empeoramiento de síntomas (disnea) o signos (taquicardia) durante las exacerbaciones agudas NO deben usarse como criterios para valorar la terminalidad; para ello siempre son más útiles las valoraciones en la situación basal del paciente.

-----O-----

A la hora de atender a pacientes en situaciones graves y complejas, ¿cuáles son las dos actitudes ESENCIALES para una buena relación médico-paciente?

1. Demostrar buenos conocimientos y asertividad.
2. Tenacidad y constancia.
3. Empatía y compasión.
4. Seguridad y destreza.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta extraña sobre la relación médico-paciente, en la que nos piden que indiquemos las dos actitudes esenciales para una buena relación médico-paciente. Todas las opciones de respuesta, excepto la 3, hacen referencia a habilidades cognitivas y laborales, mientras que la 3 hace referencia a habilidades emocionales (respuesta 3 correcta). Debes recordar que para una adecuada relación médico-paciente es necesario ser capaz de ponerse en el lugar del paciente.

-----o-----

El consentimiento informado es un formulario “ad hoc” que pretende respetar el principio de autonomía del paciente. Una de las siguientes afirmaciones es falsa:

1. Se realiza fundamentalmente de forma escrita.
2. Se requiere la firma explícita del paciente cuando éste va a ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos que pueden generar secuelas graves o riesgo vital.
3. En casos de emergencia vital se puede obviar la obtención del consentimiento informado escrito por parte del paciente.
4. El consentimiento informado siempre debe constar en la historia clínica del paciente.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El consentimiento informado es un acto verbal, aunque se debe redactar por escrito cuando el tratamiento o prueba comporte, en definitiva, riesgos notorios para la salud del paciente.

-----o-----

Según el Código Deontológico de Medicina, el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados, EXCEPTO:

1. Situaciones de catástrofe.
2. Situaciones de epidemia.
3. Exista riesgo vital inminente e inevitable para su persona.
4. Todas son ciertas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia, salvo que fuese obligado a hacerlo por la autoridad competente o exista un riesgo vital inminente e inevitable para su persona.

-----o-----

Una paciente de 16 años, bien informada y competente, sin alteraciones cognitivas, se opone a recibir el tratamiento que su médico le prescribe, a pesar de que éste le informa de que está poniendo en peligro su vida con su decisión. El médico debe:

1. Ponerse en contacto con el juez de guardia y solicitar su amparo para que la paciente reciba el tratamiento.
2. Solicitar autorización a sus padres o tutores legales para proceder al tratamiento.

3. Declarar a la paciente no apta desde el punto de vista cognitivo y proceder al tratamiento.
4. Abstenerse de tratar a la paciente.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Con 16 años si hay peligro para la vida deben decidir los padres/tutores.

Respecto a los problemas éticos en el final de la vida:

1. Para el diagnóstico de muerte encefálica se requieren pruebas complementarias
2. El principio del doble efecto marca la diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia
3. Si se decide limitar el esfuerzo terapéutico, también se limitarán los cuidados paliativos
4. En los cuidados paliativos no se incluye el soporte a la familia o cuidador del paciente terminal, ya que son medidas destinadas al paciente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El principio del doble efecto marca la diferencia entre la sedación paliativa, donde la muerte aparece como un efecto colateral y la eutanasia, donde la muerte es el objetivo directamente buscado. El diagnóstico de muerte encefálica es clínico. Aunque se limite el esfuerzo terapéutico, se deben aplicar los cuidados paliativos necesarios para asegurar al paciente una muerte lo más digna posible, con el menor de los sufrimientos.

Si en el ejercicio de su profesión el profesional sanitario se encuentra con un caso de enfermedad infectocontagiosa detallada por la Autoridad Sanitaria:

1. Podrá denunciarlo a la autoridad competente.
2. Deberá denunciarlo a la autoridad competente.
3. Su obligación de secreto profesional le impide denunciarlo.
4. Solo está obligado denunciarlo si se trata de enfermedad grave.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Existen excepciones a la obligación del secreto profesional de los profesionales sanitarios, como las situaciones que puedan suponer un peligro para la salud pública o para terceras personas. A esto se le llama Estado de Necesidad en el Código Penal art. 20.5, que consiste en la vulneración de un derecho para evitar un mal mayor. Así, los profesionales sanitarios tienen la obligación de declarar los casos de enfermedades infectocontagiosas detalladas por la Autoridad Sanitaria, con fines epidemiológicos y de prevención.

El consentimiento informado tiene por objeto PRINCIPAL:

1. Liberar al médico de responsabilidad si surgen complicaciones.
2. Evitar demandas judiciales por cualquier vía.
3. Respetar el principio de autonomía.

4. Incluir al paciente en lista de espera quirúrgica.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El consentimiento informado tiene como objetivo respetar el principio de autonomía y derecho a estar bien informado del paciente.

-----O-----

Paciente de 39 años, ADVP, que acude a urgencias por expectoración hemoptoica y febrícula. La tinción del esputo es positiva para TBC. El paciente rechaza su ingreso hospitalario. Tras comunicación al juzgado de guardia, el juez ordena el ingreso involuntario. Indique qué principio no se justifica en esta situación:

1. Autonomía
2. Beneficencia
3. No maleficencia
4. Justicia

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El principio de autonomía queda relevado por el imperativo judicial de ingreso involuntario. El resto de principios podrían ser argumentables.

-----O-----

Paciente de 45 años con diagnóstico de carcinoma de mama localmente avanzado hace tres años, que ha recibido múltiples líneas de quimioterapia, la última con taxanos y trastuzumab hace dos meses. Desde entonces sigue revisiones y tratamiento sintomático debido a progresión ganglionar y en SNC. Desde hace una semana presenta un cuadro de náuseas y vómitos refractarios al tratamiento antiemético habitual. Indique cuál de las siguientes causas le parece MENOS probable como causante del cuadro actual:

1. Hiponatremia.
2. Hipertensión intracraneal.
3. Fármacos opioides.
4. Hipocalcemia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las náuseas crónicas pueden alterar la calidad de vida de los pacientes y suelen tener un origen multifactorial. El tratamiento consiste en identificar las causas subyacentes, entre las que predominan los

fármacos opioides, la hipertensión intracraneal, la hiponatremia, la uremia, y la hipercalcemia (no la hipocalcemia).

¿Cuál de las siguientes esferas de la persona no se incluyen en la valoración de la calidad de vida?

1. Los valores del paciente.
2. La situación socioeconómica del paciente.
3. La capacidad funcional del individuo.
4. La percepción del profesional sanitario sobre la calidad de vida del paciente.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La calidad de vida es un concepto complejo, pero esencialmente individual. Si bien los profesionales pueden realizar estimaciones sobre la calidad de vida de los individuos, son los propios interesados los que deben manifestar si su vida tiene una calidad apropiada, según las circunstancias

Es correcto respecto a la autopsia clínica:

1. No la ordena el juez. Se necesita autorización de la familia.
2. Se realiza en institutos de medicina legal
3. La ordena un juez. Se necesita autorización de la familia
4. La ordena un juez. Independiente de la autorización de la familia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La autopsia clínica se realiza cuando el estudio clínico es incompleto desde el punto de vista científicoclínico. No la ordena ningún juez (a diferencia de la autopsia medicolegal) y sí se necesita la autorización de los familiares (respuesta 1 correcta). Se realiza en hospitales y centros nacionales de patología.

En el análisis de los factores que determinan el lugar de fallecimiento de los pacientes, señale la respuesta CORRECTA:

1. El tiempo de residencia en un lugar concreto condiciona de manera determinante el lugar de fallecimiento.
2. La patología de base es otro factor clave que determina el lugar de fallecimiento.
3. Los factores que más condicionan el lugar de fallecimiento son la disponibilidad de recursos sanitarios apropiados y las preferencias/capacidades del cuidador principal.
4. Las preferencias del paciente son uno de los factores de menos peso para determinar el lugar de fallecimiento.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La disponibilidad de un sistema sólido de Atención Primaria y de equipos domiciliarios de Cuidados Paliativos, así como las preferencias del Cuidador Principal y/o su sobrecarga física/emocional

son los factores más determinantes del lugar de fallecimiento.

-----O-----

Paciente de 67 años, diagnosticado de cáncer microcítico de pulmón, que presenta disnea de reposo que se agrava en decúbito, dolor torácico, cefalea, acúfenos, cianosis facial y edema en la región superior del tronco y cervicofacial. De entre las siguientes posibles etiologías del cuadro actual, señale la que le parece MÁS probable:

1. Metástasis troncoencefálica con afectación del centro respiratorio.
2. Infiltración y compresión tumoral de la vena cava superior.
3. Metástasis hepáticas con infiltración y compresión tumoral de las venas suprahepáticas.
4. Linfangitis carcinomatosa complicada con derrame pleural.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El síndrome de vena cava superior se manifiesta con disnea que empeora en decúbito, cefalea, embotamiento, visión borrosa, acúfenos, sensación de hinchazón en cara y cuello, tos, dolor torácico, disfagia, hemoptisis, ronquera, estridor, síncope y signos de edema en esclavina, cianosis facial y en extremidades superiores, circulación colateral, e ingurgitación yugular (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Entre la firma del documento de cesión de un órgano de donante vivo y su extracción, deben transcurrir AL MENOS:

1. 5 horas.
2. 24 horas.
3. 48 horas.
4. 72 horas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Entre la firma del documento de cesión del órgano y la extracción de este, deberán transcurrir al menos 24 horas (respuesta 2 correcta), pudiendo el donante revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la intervención, sin sujeción a formalidad alguna; dicha revocación no podrá dar lugar a ningún tipo de indemnización.

-----O-----

Entre las características de la comunicación con la familia, señale la INCORRECTA:

1. Escuchar activamente.
2. Evitar utilizar el lenguaje técnico.
3. Reprimir la expresión de sentimientos.
4. Graduar la información negativa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla que puede responderse con sentido común. Todas las opciones de respuesta, excepto la 3, nos indican qué hacer en una conversación con los familiares del paciente, esto es, prestar atención a sus dudas y preocupaciones, emplear un lenguaje que comprendan e informar de las malas noticias de manera gradual. Sin embargo, lo que no se debe hacer es evitar que la familia exprese sus sentimientos (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

Indica lo que es FALSO:

1. Aunque los cuidadores de EA quieren conocer el diagnóstico si ellos fueran los afectados, más de la mitad quiere ocultar el diagnóstico a su familiar para evitar una depresión.
2. Más del 90 % de los pacientes quiere conocer su diagnóstico para planificar su vida.
3. La información disponible en internet y en los medios de comunicación no está modificando la relación médico paciente.
4. La mayoría de los médicos desearía ser informado del diagnóstico si tuviera Enfermedad de Alzheimer aunque no se lo dice siempre a sus pacientes.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En las últimas décadas ha aparecido un nuevo tipo de usuario de la sanidad, denominado “activo”, “experto” o “inteligente”. En definitiva, resalta la existencia de un nuevo rol del paciente en el sistema sanitario que conlleva la necesaria aparición de un tipo de relación denominada “relación consensual”, “reconocimiento recíproco”, o, como propugnamos, “Nuevo Paternalismo”.

-----O-----

Señale la respuesta CORRECTA sobre la doctrina actual del derecho respecto a los casos de rechazo:

1. El respeto a la decisión del médico es el criterio jurídico fundamental, puesto que siempre pretende un beneficio del paciente.
2. La decisión del paciente está por encima de la decisión del médico en toda situación, incluyendo las situaciones de riesgo vital, solamente cuando el paciente sea perfectamente capaz de tomar la decisión y en ausencia de imposiciones externas.
3. La decisión del paciente y por tanto el respeto a su autonomía es el principio jurídico fundamental. Se deberá respetar la decisión del paciente en todos los casos aunque no esté probada su perfecta capacidad para tomar decisiones.
4. El respeto a la autonomía del paciente es el principio jurídico fundamental y hay que respetar siempre las decisiones de rechazo excepto en situaciones de riesgo vital.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Se aplica el principio de autonomía respetando el derecho del paciente y cuya decisión se encuentra por encima de la del médico.

-----O-----

El principio que implica por parte del profesional sanitario hacer el bien, se denomina:

1. Principio deontológico.
2. Principio de Justicia.
3. Principio de beneficencia.
4. Principio de no maleficencia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Hacer el bien, obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo perjuicios. Se debe promover el interés del paciente, así se considera que por la formación que posee el profesional sanitario, sabe lo más conveniente para aquél.

-----O-----

Recibe usted a un paciente ingresado a su cargo en el hospital desde el Servicio de Urgencias la noche anterior. En la reunión de primera hora, la enfermera le informa de que está intranquilo. ¿Cuál de las siguientes actitudes debe EVITAR?

1. Leer el informe de Urgencias y solicitar las pruebas urgentes que estime convenientes, y que deban realizarse en ayunas.
2. Modificar el tratamiento según la impresión de la enfermera y los signos vitales disponibles en la gráfica.
3. Realizar la Histórica Clínica, anamnesis, exploración física, y registrar todo ello en el sistema de documentación clínica del hospital, dejando constancia de la impresión diagnóstica y del plan.
4. Informar al paciente y a la persona que entiende en su caso de las perspectivas del ingreso.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Antes de modificar el tratamiento o la actitud con un paciente, más cuando procede de otro Servicio (en este caso procedente del Servicio de Urgencias), es imprescindible realizar una correcta anamnesis y exploración física, así como revisar los datos registrados durante su estancia en Urgencias (respuesta 2 correcta). En cualquier caso, es necesario informar al paciente de manera clara y que entienda su situación y manejo clínico.

-----O-----

Antonia es una mujer de 55 años que acude a su consulta de Atención Primaria por dolores generalizados. Es la cuarta vez que acude a su consulta por el mismo problema, y, tras realizarle la adecuada Historia Clínica y exploración física, procede a modificarle el tratamiento. En ese momento, la paciente le comenta que una amiga suya ha probado “una planta del herbolario que le ha solucionado todos los problemas”. La paciente no sabe especificar la planta o el nombre del producto. A continuación, Antonia le pide su opinión, ya que confía en usted por ser “su médico de toda la vida”. ¿Qué debería decirle a Antonia?

1. Que no es legal el uso de productos que carecen de base científica, y, por tanto, no debería utilizarlos.
2. Que no es moral el uso de productos que carecen de base científica, y, por tanto, no puede recomendárselos.
3. Que no es ética la prescripción de productos que carecen de base científica, y, por tanto, no puede recomendárselos.
4. Que no puede prescribir productos que carecen de base científica, pero puede recomendárselos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El médico debe prescribir fármacos demostrados científicamente. Asimismo, no son éticas las prácticas carentes de evidencia científica; sin embargo, hay productos que se venden en farmacias y herbolarios, por lo que no son ilegales, aunque no estén demostrados científicamente. Se describe en el Apartado 1 y 2 del Artículo 26 del Código de Deontología Médica que "el médico debe emplear preferentemente procedimientos y prescribir fármacos cuya eficacia se haya demostrado científicamente". "No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida" (respuesta 3 correcta).

-----O-----

En relación al síndrome confusional en cuidados paliativos, señale la afirmación FALSA:

1. El haloperidol es el fármaco de primera línea para el tratamiento del síndrome confusional.
2. Se han utilizado con buenos resultados los nuevos fármacos antipsicóticos atípicos por vía intravenosa, como la olanzapina y la risperidona.
3. En pacientes con agitación terminal es útil el empleo de haloperidol, clorpromacina y benzodiacepinas como el midazolam.
4. En algunos pacientes se puede usar la vía subcutánea en infusión continua.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los nuevos antipsicóticos como la olanzapina y la risperidona han sido utilizados por vía intramuscular, no por vía intravenosa. Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

En cuidados paliativos, ¿cuál de las siguientes situaciones sería SUSCEPTIBLE de colocación de una sonda nasogástrica?

1. Candidiasis orofaríngea.
2. Paciente con vómitos secundarios a tratamiento quimioterápico.
3. Atonía gástrica severa con vómitos.
4. Paciente en situación terminal con caquexia muy severa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las indicaciones de colocación de sonda nasogástrica por vómitos son muy escasas y se reducen a los casos de obstrucción gástrica total y casos de atonía gástrica muy severa que no responde a otras medidas (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Si un profesional sanitario atiende a personas con enfermedades que puedan suponer un peligro para la salud pública:

1. Podrá denunciarlo a la autoridad competente
2. Deberá denunciarlo a la autoridad competente

3. Su obligación de secreto profesional le impide denunciarlo
4. Sólo está obligado denunciarlo si se trata de enfermedad grave

Resp. Correcta: 2

Comentario: Existen excepciones a la obligación del secreto profesional de los profesionales sanitarios: - Situaciones que puedan suponer un peligro para la salud pública o para terceras personas. A esto se le llama Estado de Necesidad en el Código Penal art. 20.5, que consiste en la vulneración de un derecho para evitar un mal mayor. Así, los profesionales sanitarios tienen la obligación de declarar los casos de enfermedades infecto-contagiosas detalladas por la Autoridad Sanitaria, con fines epidemiológicos y de prevención.

-----O-----

Ingresa en nuestra planta desde Urgencias para estudio un paciente de 80 años refiriendo pérdida de peso y malestar inespecífico centroabdominal, junto a pérdida de apetito. El proceso diagnóstico que debemos desarrollar durante su ingreso será guiado por los siguientes principios EXCEPTO:

1. Se realizarán todas aquellas pruebas que puedan aportar luz al proceso sospechado por el médico cubriendo el más amplio diagnóstico diferencial desde el comienzo.
2. El proceso asistencial se adaptará al contexto clínico individual del paciente y se buscará que éste sea participe de las decisiones relativas al diagnóstico y tratamiento.
3. Es importante pensar en primer lugar en lo más corriente, para sólo después, una vez descartadas con certeza las entidades más frecuentes, considerar lo raro.
4. Algunas pruebas complementarias pueden ser redundantes y no aportar valor al proceso diagnóstico, pero si al coste sanitario. Así, ante dos pruebas complementarias de rendimiento similar, se decidirá siempre por la más económica y de menor riesgo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta, aborda una situación clínica muy habitual, enfrentarnos a un diagnóstico de un paciente para ello, lo primero que debemos hacer es lo que nos dicen la opción 3, debemos iniciar nuestra sospecha clínica en aquellas patologías más frecuentes e ir posteriormente pensando en otros diagnósticos menos probables.

No debemos olvidar lo que nos dice la opción 2, puesto que resulta de vital importancia que adaptemos el proceso asistencial al contexto clínico del paciente (situación basal) y debe ser participe en la toma de decisiones (consentimiento informado y principio de independencia del paciente).

Si existen dos pruebas complementarias que puedan ser redundantes deberemos primar en nuestra elección en primer término la que menos riesgos y complicaciones tenga para el paciente y en un segundo término la menos costosa.

Por todo lo anteriormente expuesto, la respuesta que debemos marcar como falsa en esta pregunta es la opción 1, puesto que la elección de las pruebas complementarias debe ir relacionada con la evolución del paciente, sospecha clínica y teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente ("primum non nocere", situación basal del paciente, principio de independencia). No se trata de cubrir el "más amplio diagnóstico diferencial desde el comienzo" sino de realizar pruebas dirigidas evitando daños/molestias innecesarias.

-----O-----

En el síndrome de enclaustramiento:

1. La conciencia se ve afectada parcialmente
2. La conciencia no se ve afectada
3. No hay evidencia de conciencia de sí mismos o del entorno
4. Puede ser elegido para donar órganos

Resp. Correcta: 2

Comentario: En el síndrome de enclaustramiento la conciencia no se ve afectada. Se debe a una lesión en la protuberancia (no en la corteza cerebral), y por ello no es un trastorno de la conciencia como el estado vegetativo o el estado de mínima conciencia. Conservan la capacidad cognitiva pero están completamente paralizados y son incapaces de hablar o de moverse. Para donar órganos el paciente debería cumplir criterios de muerte encefálica.

-----O-----

De entre los siguientes fármacos útiles en la sedación de un paciente oncológico terminal, uno de ellos es el MENOS empleado en la práctica clínica habitual. Señálelo:

1. Midazolam.
2. Haloperidol.
3. Propofol.
4. Levomepromacina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los fármacos más empleados de forma aislada o en combinación para la sedación son: midazolam (de elección), muchas veces morfina y un neuroléptico como haloperidol o levomepromacina. Si con los anteriores no se logra la sedación, el fenobarbital o el propofol son una alternativa (respuesta 3 correcta). Éste último es muy útil por su rapidez de acción y por la rápida reversión del estado de alerta una vez finalizada la infusión.

-----O-----

Una mujer de 82 años es ingresada en el hospital por cansancio y molestias digestivas, y es diagnosticada de cáncer de colon mediante colonoscopia. Es viuda. Sus médicos estiman que es competente y capaz de tomar decisiones. Sus hijos refieren que ellos siempre han tomado las decisiones por su madre e insisten en que a ella no se le haga ninguna referencia al cáncer, con amenaza de demanda si se le dice algo relativo al mismo. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es la MÁS apropiada por parte de los médicos?

1. Preguntar a la paciente si quiere que sus médicos le den la información sobre su enfermedad a ella o a sus hijos.
2. Aceptar los deseos de los hijos y pedir a todo el personal involucrado en el tratamiento que no le digan a la paciente que tiene cáncer.
3. Explicar a los hijos que los médicos están obligados a dar a la paciente toda la información relevante sobre su problema médico.
4. Pedir a sus hijos que estén presentes cuando le digan a su madre que tiene cáncer.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta nos presentan el caso de una mujer capaz que es diagnosticada de una enfermedad grave. En estos casos, lo correcto es preguntar a la paciente si quiere ser informada de su situación, y si desea que informemos a sus familiares (respuesta 1 correcta). Lo que sería éticamente incorrecto sería no informar deliberadamente a la paciente, ya sea por decisión nuestra o de la propia familia.

-----o-----
¿Cuál de las siguientes NO es una condición para que se lleve a cabo el principio del doble efecto?

1. Presencia de intencionalidad primaria del efecto negativo.
2. Efecto positivo: disminuir el sufrimiento. Efecto negativo: sedación y acortamiento del tiempo de vida.
3. Búsqueda de un beneficio primario.
4. Proporcionalidad entre ambos efectos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En la sedación paliativa se busca paliar un síntoma (no el acortamiento del tiempo de vida). El principio del doble efecto permite y justifica este efecto: no se busca acortar la vida; si esto sucede es por un efecto derivado de la propia enfermedad que padece el paciente y de los fármacos utilizados (marcamos la opción de respuesta 1).

-----o-----
Las declaraciones legales que permiten a las personas articular valores y establecer preferencias terapéuticas que deberán ser respetadas en el futuro si pierden su capacidad se denominan:

1. Consentimiento informado.
2. Directrices anticipadas.
3. Capacidades legales.
4. Principio de autonomía.

Resp. Correcta: 2

Comentario: También se pueden denominar voluntades anticipadas o testamento vital

-----o-----
Una mujer de 78 años es ingresada en el hospital por astenia y anorexia. Tras realizar las pruebas complementarias correspondientes es diagnosticada de cáncer de colon ascendente. Sus médicos aseguran que está en plenas facultades mentales, pero su marido insiste en que no se le comunique nada acerca del diagnóstico. Señale cuál de las siguientes actuaciones le parece MÁS adecuada:

1. Aceptar el deseo de su marido y no comunicar a la paciente nada acerca del diagnóstico.
2. Preguntar a la paciente si quiere ser informada y si desea que su familia reciba información acerca de su proceso.

3. Indicar al marido que como médico tiene el deber de trasladar toda la información a la paciente.
4. Informar conjuntamente a la paciente y a su marido y recomendarles apoyo psicológico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La opción de respuesta 2 defiende el derecho de autonomía de la paciente, con lo que se puede considerar la más adecuada en esta situación.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes no es uno de los principios clásicos de bioética?

1. Autocracia
2. No maleficencia
3. Beneficencia
4. Justicia

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La autocracia no forma parte de los principios de la bioética.

-----O-----

El sujeto participante en un ensayo clínico, ¿cuándo podrá revocar su consentimiento?

1. En cualquier momento.
2. Antes del final del ensayo.
3. Al inicio del ensayo.
4. No podrá revocarlo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El sujeto participante en un ensayo clínico podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin expresión de causa y sin que por ello se derive para el sujeto participante responsabilidad ni perjuicio alguno (respuesta 1 correcta).

-----O-----

Uno de ellos NO es un sinónimo de “instrucciones previas”:

1. Voluntades anticipadas
2. Testamento vital
3. Documento de fase terminal
4. Directivas anticipadas

Resp. Correcta: 3

Comentario: El resto de opciones son todas sinónimos del concepto de instrucciones previas.

-----o-----

Mujer de 79 años, diagnosticada de insuficiencia cardiaca en estadio 4 de la NYHA, que ingresa por aumento de su disnea y anasarca. Durante el ingreso la paciente presenta además fallo renal refractario a tratamiento con furosemida. Señales cuál de las siguientes actitudes le parece MÁS adecuada:

1. Administrar morfina hasta que ceda la disnea y comenzar diálisis urgente.
2. Comunicar a la familia que la paciente va a morir y no se puede hacer nada por ella.
3. Informar al paciente y a la familia del mal pronóstico de la situación e indicar tratamiento sintomático paliativo.
4. Aumentar la dosis de furosemida e iniciar tratamiento con eplerenona.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Nos encontramos ante una paciente en situación terminal, por lo que es importante evitar medidas diagnósticas o terapéuticas agresivas. Lo más indicado es informar a la paciente (siempre que se pueda es lo primero) y a la familia y allegados (cuando sea pertinente) del mal pronóstico de la situación y plantear medidas paliativas para garantizar el confort de la esta (respuesta 3 correcta).

-----o-----

Con respecto a la comunicación en el ámbito clínico, es INCORRECTO que:

1. En ocasiones resulta difícil para los profesionales por miedo a hacer daño al enfermo al dar malas noticias.
2. Es un proceso complejo que va mucho más allá de la competencia técnica y que requiere una continua formación, no solo en habilidades comunicativas, sino en el entrenamiento de ciertas actitudes éticas básicas.
3. Es un don innato, que o se tiene, o no se tiene.
4. Tiene aspectos muy automatizados y a veces no somos conscientes de cómo lo hacemos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Hay personas que comunican mejor de manera innata, pero aun así es posible enseñar y aprender a dar malas noticias en situaciones complejas (opción 3 incorrecta, por lo que la marcamos). El tema de la comunicación ha sido ampliamente tratado por Pilar Arranz y colaboradores en el libro: "Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelo y protocolos". Barcelona: Ariel; 2004.

-----o-----

Una paciente de 47 años es diagnosticada de carcinoma lobulillar infiltrante de mama con metástasis suprarrenales y óseas. Tras ser informada de las opciones terapéuticas y su pronóstico decide no someterse al tratamiento. De entre las siguientes opciones, señale aquella que no estaría indicada:

1. Intentar convencerla de que se someta al tratamiento con argumentos sólidos y estructurados.

2. Poner el caso en conocimiento de su familia para que ellos la obliguen a someterse al tratamiento.
3. Respetar la decisión de la paciente de no recibir el tratamiento, aunque su pronóstico vital empeore a corto plazo.
4. Intentar buscar otras opciones terapéuticas que pudieran ser efectivas en este caso.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La opción 2 es incorrecta, pues no estaría indicado.

-----O-----

Paciente de 69 años, fumador, sin otros antecedentes de interés, que acude a su consulta de Atención Primaria con un cuadro de tos, sin fiebre ni expectoración. Se le realiza una Rx de tórax en la que se observa una opacificación completa del LSD. Tras dichos hallazgos, se le realiza una TC de tórax donde se observa tumoración broncogénica con adenopatías mediastínicas múltiples y metástasis hepáticas en ambos lóbulos. Posteriormente se somete a fibrobroncoscopia con toma de biopsia que confirma el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón. Señale cuál es la actitud MÁS adecuada:

1. Informar al paciente de su diagnóstico si este lo desea, intentando resolver sus dudas iniciales sobre la enfermedad y el proceso de tratamiento.
2. Derivar al paciente a una consulta de oncología para que le comuniquen el diagnóstico y todo lo que necesite saber acerca de la enfermedad y del tratamiento.
3. No decirle la verdad acerca del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, evitando la palabra cáncer en la explicación.
4. Preguntar a la familia si quiere que el paciente conozca su diagnóstico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Ante un nuevo diagnóstico de cáncer debemos explicar rigurosamente todo lo que el paciente desee y necesite conocer sobre la enfermedad y las actitudes terapéuticas. La opción de respuesta 2 no se puede considerar correcta de inicio, ya que no se debe demorar la comunicación sobre el diagnóstico a que el paciente acuda a la consulta de Oncología, ya que esto genera una gran ansiedad en los pacientes. El médico de Atención Primaria debe intentar responder las dudas iniciales del paciente, siempre acorde a sus conocimientos sobre la materia determinada (respuesta 1 correcta).

-----O-----

Un paciente de 76 años, diagnosticado hace unos 18 meses de adenocarcinoma de estómago irresecable, con extensión locorregional y en tratamiento con quimioterapia. Ingresa por intolerancia a la ingesta por vómitos reiterados, con fiebre y disnea. Se comprueba radiológicamente progresión de la enfermedad tumoral y una bronconeumonía bilateral con insuficiencia respiratoria, deterioro de la función renal y coagulopatía. Se decide iniciar antibioterapia de amplio espectro y nutrición e hidratación por vía parenteral, pero el paciente expresa su negativa a todo ello. En este caso concreto:

1. Su médico está obligado a instaurar un tratamiento, aún en contra de la voluntad del paciente, si éste sufre una situación clínica amenazante para su vida.

2. Plantearemos la situación a sus familiares o representante legalmente designado y actuaremos de acuerdo con ellos, aunque su opinión no coincida con la del paciente.
3. Informaremos al paciente de los pros y de los contras de su decisión, y respetaremos la que adopte, aunque pueda conllevar un desenlace fatal.
4. Está indicado no emprender otro tratamiento que no sea el de sedación por sufrir neoplasia terminal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La opción de respuesta correcta es la 3, ya que nos encontramos ante un caso de rechazo al tratamiento y es la única que respeta el principio de autonomía del paciente. El principio de autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se den situaciones en que las personas puedan no ser autónomas o presenten una autonomía disminuida (personas en estado vegetativo o con daño cerebral, etc.), en cuyo caso será necesario justificar por qué no existe autonomía o por qué esta se encuentra disminuida. El rechazo a las actuaciones médicas se define como la no aceptación, voluntaria y libre, de una intervención médica diagnóstica o terapéutica indicada. El rechazo traduce la fidelidad del paciente con sus valores, creencias o deseos íntimos. Es importante diferenciar el rechazo a las actuaciones médicas de la limitación del esfuerzo terapéutico (LET).

-----O-----

En el paciente oncológico terminal, una de las siguientes afirmaciones sobre la morfina es FALSA. Señálela:

1. La morfina oral suele ser efectiva en los pacientes paliativos.
2. La morfina tiene techo terapéutico, que hay que tener en cuenta para no producir efectos secundarios graves como la depresión respiratoria.
3. La morfina intravenosa es más potente que la morfina subcutánea.
4. La tolerancia a la morfina se desarrolla lentamente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La morfina se caracteriza por no tener techo terapéutico. Las equivalencias entre las vías de administración de morfina son: oral 3 – subcutánea 2 – intravenosa 1. Aunque se produce el fenómeno de tolerancia, cuanto más prolongado es el tratamiento con morfina, menor intensidad tiene dicho fenómeno.

-----O-----

La agonía es el estado que precede a la muerte. Entre los signos y síntomas que presenta el paciente en la agonía se encuentran todos los siguientes, EXCEPTO:

1. Percepción de la realidad de la situación.
2. Estado de alerta, desorientación y trastornos en la comunicación.
3. Alteración de los esfínteres.
4. Dificultad para la ingesta.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En la fase de agonía los pacientes habitualmente presentan una notable disminución del nivel de conciencia,

desorientación y trastornos de la comunicación (marcamos la opción de respuesta 2). Las demás opciones de respuesta son correctas.

-----O-----

En el concepto de ética de máximos se incluyen los siguientes principios:

1. Justicia y no maleficencia.
2. Justicia y beneficencia.
3. Autonomía y no maleficencia.
4. Autonomía y beneficencia.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En la ética de máximos se incluyen los principios de autonomía y beneficencia. La ética de máximos es individual, depende de los valores de cada uno (la libertad/autonomía, y cuánto de bueno debemos ser, la beneficencia).

La ética de mínimos es social y en ella se incluye la no maleficencia (no hacer daño) y la justicia, ya que son aspectos que incumben a todos y pueden incluso exigirse a través de las leyes.

-----O-----

En el caso de que se recabe el consentimiento de la Autoridad Judicial para realizar la transfusión de sangre a un menor:

1. Primará el principio de curar sobre el derecho a la libertad religiosa.
2. Primará el derecho a la libertad religiosa sobre el de curar.
3. Se valorará en cada caso concreto a lo que dar preferencia.
4. Primará la decisión del médico responsable.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La negativa a recibir transfusiones sanguíneas por parte de miembros de determinados grupos religiosos por considerarlas contrarias a sus creencias: Si el paciente es mayor de 16 años, con plena capacidad, se debe respetar su decisión. Si el paciente es un menor de edad o incapaz, y la renuncia a la transfusión es realizada por su representante, se debe de recabar el consentimiento de la autoridad judicial, en el que primará el principio de curar sobre el de la libertad religiosa.

-----O-----

El principio que implica por parte del profesional sanitario hacer el bien, se denomina:

1. Pº deontológico
2. Pº de Justicia
3. Pº de beneficiencia
4. Pº de no maleficiencia

Resp. Correcta: 3

Comentario: Hacer el bien, obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo perjuicios. Se debe promover el interés del paciente, así se considera que por la formación que posee el profesional sanitario, sabe lo más conveniente para aquél.

-----O-----

Si un profesional sanitario atiende a personas que hayan podido ser víctimas de delito:

1. Podrá denunciarlo a la autoridad competente.
2. Deberá denunciarlo a la autoridad competente.
3. Su obligación de secreto profesional le impide denunciarlo.
4. Solo está obligado denunciarlo si se trata de menores.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los profesionales sanitarios están obligados a denunciar a la autoridad competente aquellos casos en los que atiendan a personas que hayan podido ser víctimas de delito.

-----O-----

El principio bioético que defiende que los pacientes deben ser tratados con el objetivo de lograr su mejor interés, se corresponde con:

1. Autonomía.
2. Beneficencia.
3. No maleficencia.
4. Justicia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La definición hace referencia al principio bioético de beneficencia (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Todas las siguientes situaciones son indicación de administrar sedación paliativa, excepto una, señálela:

1. Paciente con colangiocarcinoma localmente avanzado que presenta obstrucción de la vía biliar intrahepática que comienza con ictericia y disminución del nivel de conciencia en relación con encefalopatía hepática.
2. Paciente con adenocarcinoma gástrico con metástasis hepáticas, ganglionares y óseas que presenta agitación sin respuesta a tratamiento neuroléptico.
3. Paciente con carcinoma microcítico de pulmón que presenta disnea refractaria a morfina subcutánea y diazepam oral.
4. Paciente con carcinoma epidermoide de base de lengua con infiltración carotídea que presenta hematemesis franca.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La opción numero 1 no es indicación de sedación paliativa.

La alimentación es un símbolo de salud y actividad. En la situación de enfermedad terminal es frecuente que enfermos y familiares refieran problemas relacionados con esta. Todas las siguientes afirmaciones con respecto a la alimentación en enfermos terminales son correctas, EXCEPTO:

1. La nutrición y la alimentación no son objetivos en sí mismos en la atención de enfermos terminales con cáncer.
2. Se debe fraccionar la dieta en 6-7 tomas y flexibilizar mucho los horarios según el deseo del enfermo.
3. La adición de complejos vitamínicos tiene una eficacia demostrada en enfermos terminales, excepto en situaciones muy concretas.
4. No se debe insistir en nutriciones hipercalóricas o hiperproteicas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La adición de complejos vitamínicos o de hierro oral es de muy dudosa eficacia en enfermos terminales, excepto en situaciones muy concretas (respuesta 3 correcta). Las demás opciones de respuesta son correctas.

¿Cómo debe ser el consentimiento informado de las personas que participen en una investigación biomédica?

1. Siempre por escrito.
2. Por escrito o verbal.
3. Ante la Autoridad Judicial.
4. No pueden participar en la investigación.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Será siempre necesario el consentimiento informado por escrito de las personas que participen en una investigación biomédica.

El principio que implica la capacidad del paciente para tomar decisiones por uno mismo sin influencia de personas externas, se denomina principio de:

1. Principio de autonomía.
2. Principio de justicia.
3. Principio de consentimiento informado.
4. Principio de libertad.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El principio de autonomía implica la capacidad de tomar decisiones por uno mismo sin influencia de personas externas (respuesta 1 correcta). Este principio se respetará, salvo cuando se den situaciones en que

las personas no sean autónomas o estén incapacitadas. El consentimiento informado es la máxima expresión de este principio, constituyendo un derecho del paciente y un deber del profesional sanitario.

-----O-----

Señale qué principio ético requiere la solicitud de consentimiento informado para la participación del paciente en técnicas de reproducción asistida:

1. Justicia.
2. No maleficencia.
3. Capacidad legal.
4. Autonomía.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El consentimiento informado tiene como objetivo respetar el principio de autonomía y derecho a estar bien informado del paciente en cualquier situación médica que así lo exija.

-----O-----

De entre los siguientes, ¿qué principios se incluyen en el marco de la ética de mínimos?

1. Justicia y no maleficencia.
2. Justicia y autonomía.
3. Autonomía y beneficencia.
4. Autonomía y no maleficencia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En el marco de la ética de mínimos se incluyen el principio de no maleficencia y el de justicia (respuesta 1 correcta). La ética de máximos es individual, depende de los valores de cada uno (la libertad/autonomía, y cuánto de bueno debemos ser, la beneficencia). La ética de mínimos es social y en ella se incluye la no maleficencia (no hacer daño) y la justicia, ya que son aspectos que incumben a todos y pueden incluso exigirse a través de las leyes.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes NO es un criterio habitualmente utilizado para definir la situación de terminalidad?

1. Que se trate de una enfermedad avanzada sin posibilidades de mejoría.
2. El alto impacto emocional sobre el paciente y la familia.
3. El pronóstico vital estimado inferior a un año.
4. La progresiva fragilidad del paciente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El paciente terminal es aquel que cumple los siguientes criterios:

- Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva o incurable.

- Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo específico para la patología subyacente.
- Presencia de sintomatología intensa, múltiple, multifactorial y cambiante.
- Impacto emocional en el paciente, en su familia y/o equipo terapéutico.
- Pronóstico de vida limitado a semanas o meses (marcamos la opción de respuesta 3).

-----o-----

Un paciente, conocido por su mal carácter y actitud poco amable, acudió a su consulta del centro de Atención Primaria hace unos días por un cuadro compatible con una bronquitis aguda. Tras la correspondiente evaluación, usted prescribió amoxicilina-clavulánico. El paciente acude de nuevo al segundo día por falta de mejora. En la exploración no encuentra datos que hagan replantear el diagnóstico, pero evidencia un exantema maculopapuloso difuso y observa que, en la historia del paciente, constaba el antecedente de alergia a la penicilina, que no había apreciado en la visita anterior. ¿Cuál cree que es la actitud MÁS adecuada?

1. Comentarle al paciente que el tratamiento no parece haber sido efectivo y cambiar el antibiótico, evitando más comentarios que puedan comprometerle. Ofrecerle un nuevo control en pocos días.
2. Comentarle al paciente que el tratamiento de la bronquitis puede ser fundamentalmente sintomático y que los antibióticos no necesariamente son efectivos, por lo que, dada la evolución, lo más aconsejable es suspender la amoxicilina-clavulánico e iniciar tratamiento sintomático, con nuevo control en pocos días.
3. Comentar que la presencia del exantema puede ser un efecto adverso de la medicación, pues la amoxicilina-clavulánico, que no es lo mismo que la penicilina, puede en ocasiones tener reacciones cruzadas con la misma, y que es mejor suspender toda medicación y ver evolución. Ofrecerle un nuevo control en pocos días.
4. Comentar que la presencia del exantema puede ser un efecto adverso de la medicación, pues la amoxicilina-clavulánico forma parte de la familia de las penicilinas, y que usted, en la anterior visita, no se percató de que el paciente era alérgico a la misma. Suspenderla en consecuencia, pedir excusas, proponer un tratamiento sintomático y ofrecerle un nuevo control en pocos días.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta se nos plantea un caso en el que se comete un error al prescribir un tratamiento, en este caso uno al que el paciente es alérgico. Lo que nunca se debe hacer es mentir u ocultar información. Lo más correcto sería informar al paciente de manera clara y sencilla del error ocurrido, suspender dicho tratamiento, pautar uno nuevo que no presente contraindicaciones, y solicitar control para vigilar la aparición de posibles complicaciones futuras (respuesta 4 correcta).

-----o-----

Con respecto a la información en la relación clínica, es CIERTO que:

1. El derecho a la información sanitaria corresponde solo a la persona enferma, no a la sana.
2. La insatisfacción laboral y la sobrecarga asistencial afectan negativamente al derecho de información del paciente.
3. Información y comunicación son sinónimos.
4. Cuando la información incluya datos de gravedad o mal pronóstico no es necesario decírselo al

paciente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El derecho a la información sanitaria corresponde no solo a la persona enferma, sino también a la sana, para acceder a su derecho a la protección de la salud, lo que permitirá adoptar medidas de carácter preventivo o actitudes de vida que puedan redundar en su mejor estado de salud. La satisfacción profesional afecta a la satisfacción del paciente. Los resultados obtenidos de diferentes trabajos ponen de manifiesto que la satisfacción profesional y la sobrecarga asistencial medida como número de tarjetas sanitarias asociadas a cada médico de Atención Primaria se asocian significativamente con la información proporcionada a los pacientes. De manera general se observa que hay un aumento progresivo del número de profesionales que informa siempre a medida que se incrementa la satisfacción profesional, y que los profesionales con menor número de tarjetas sanitarias informan más adecuadamente a sus pacientes (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Los familiares de un paciente recientemente dado de alta de un hospital solicitan al Servicio de Atención al Usuario del mismo la Historia Clínica completa de un paciente, sin especificar el motivo. ¿Cuál es la actitud ADECUADA?

1. El hospital no la facilitará porque la Historia Clínica de un paciente no puede salir del centro.
2. Los familiares no la pueden solicitar. Lo tiene que hacer el propio paciente.
3. El hospital tiene que facilitarla sin condiciones porque el propietario de la Historia Clínica es el paciente.
4. Se facilitará el informe de todas las exploraciones complementarias y los comentarios generados por los médicos responsables cuando estos lo consideren oportuno.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Una pregunta difícil, ya que nos exige ciertos conocimientos sobre la Ley de Autonomía del paciente. Veamos opción por opción:

- 1.- Esta opción se descarta, ya que esta ley garantiza el derecho del paciente a acceder a su Historia Clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella.
- 2.- Efectivamente, es el propio paciente el que debe solicitarla. En ciertos casos, el paciente puede obtener su Historia Clínica por representación de familiares u otras personas vinculadas a él, debidamente acreditada. Sin embargo, el enunciado de la pregunta lo deja claro: "sin especificar el motivo". Mientras no exista alguna razón especial debidamente documentada (por ejemplo, que el paciente esté incapacitado o sea un menor), no existen razones para entregar la Historia Clínica a un familiar.
- 3.- Podría entregarse al paciente si la solicita, pero no a sus familiares, porque en este caso no existen motivos para hacerlo, como se ha explicado en el párrafo anterior.
- 4.- Tampoco es correcto que el propietario único de la Historia Clínica sea el paciente, sino también del centro hospitalario y de los médicos que en ella intervienen. Sin embargo, la entrega de la Historia Clínica es un derecho que el paciente puede ejercer libremente y no depende de voluntad de los médicos.

-----O-----